



MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE



MANUEL DE PROCEDURES POUR LA GESTION LOGISTIQUE DES INTRANTS DE SANTE

MARS 2016

MANUEL DE PROCEDURES POUR LA GESTION LOGISTIQUE DES INTRANTS DE SANTE

MARS 2016

Table des Matières

Abreviations	v
Remerciements	vii
Préface.....	ix
Questions fréquemment posées	I
I. Introduction à la Logistique	3
II. Rôles et Responsabilités du Personnel Impliqué dans la Gestion des Intrants de Santé	7
III. Système d'Information de Gestion Logistique	13
Les Aide-Memoires	15
IV. Le Système de Contrôle d'Inventaire	51
La commande forcée	51
Les niveaux de stock.....	53
Evaluation de l'État de Stock.....	53
Commande des intrants de santé.....	56
Commande d'Urgence.....	57
V. Réception et Emmagasinage.....	59
Réception des intrants de santé.....	59
Stockage des intrants de santé	59
Inspection visuelle.....	62
Figures	
Figure 1. Chaîne Nationale de Distribution des Intrants de Santé et Flux de l'Information.....	6
Tableaus	
Tableau 1. Rôles et Responsabilités	8
Tableau 2. Liste des supports par niveau.....	14
Tableau 3 : Soumission de « Rapport – Bon de Commande » des formations sanitaires	52
Tableau 4 : Niveaux de stock par catégorie de structure/formation sanitaire.....	53
Tableau 5 : Directives pour un bon entreposage	60
Tableau 6 : Les différentes étapes d'un inventaire physique	61

Abbreviations

AC	Agent Communautaire
CHRD1	Centre Hospitalier de Référence de District niveau 1
CMM	Consommation Moyenne Mensuelle
CoGe	Comité de Gestion
CU	Commande d'urgence
CSB1	Centre de Santé de Base niveau I
CSB2	Centre de Santé de Base niveau 2
DCI	Dénomination Commune Internationale
DPLMT	Direction de la Pharmacie, des Laboratoires et de la Médecine Traditionnelle
DRSP	Direction Régionale de la Santé Publique
EQD	Evaluation de la Qualité des Données
FANOME	Financement pour l'Approvisionnement Non-stop en Médicaments
IS	Intrants de santé
LNMEIS	Liste Nationale des Médicaments Essentiels et des Intrants de santé
MGA	Malagasy Ariary
MI	Médecin Inspecteur
MSD	Mois de Stock Disponible
ONG	Organisation Non Gouvernementale
Pha-G-Dis	Pharmacie de Gros de District
Pha-Ge-Com	Pharmacie à Gestion Communautaire
PPPS	Premier Périmé Premier Sorti
PTF	Partenaires Techniques et Financiers
PU	Prix Unitaire
PV	Procès Verbal
PVRD	Procès-verbal de Réception Définitive
QàC	Quantité à Commander
RUMER	Registre d'Utilisation des Médicaments et des Recettes journalières
SDSP	Service de District de Santé Publique
SDU	Stock Disponible et Utilisable

SGIS	Service de Gestion des Intrants de Santé
SIGL	Système d'Information de Gestion Logistique
SM	Stock Maximum
UASM	Unité d'Approvisionnement en Solutés Massifs
UTGL	Unité Technique de Gestion Logistique
USAID	Agence des Etats Unis pour le Développement International
TTC	Toutes Taxes Comprises

Remerciements

Nous tenons, par la présente, à remercier tous ceux qui, de loin ou de prêt, ont contribué à la conception et à l'élaboration de ce manuel.

Nous remercions particulièrement le personnel du ministère de la santé et tous les partenaires techniques et financiers pour leur participation effective et remarquable à la production du manuel.

Nous ne pouvons pas ne pas citer la contribution principale de l'Agence Américaine pour le Développement International, en sigle USAID, sous son projet USAID | DELIVER PROJECT mis en œuvre à Madagascar par John Snow Inc. (JSI). Sans son appui, la finalisation et la production de ce manuel ne serait pas possible.

Que tous trouvent ici l'expression de notre profonde considération.

Préface

Le Ministère de la Santé Publique, par le biais de la Direction de la Pharmacie, des Laboratoires et de la Médecine Traditionnelle (DPLMT), a pour mission d'assurer la disponibilité et l'accessibilité des intrants de santé (IS) de qualité à tous les niveaux du système de santé. Dans cette optique, sous l'égide du Ministère de Santé Publique, une étude préalable a été effectuée, d'une part pour mettre en exergue l'existant, et d'autre part, de définir la stratégie et les étapes à suivre pour atteindre l'objectif.

Ainsi, pour améliorer la gestion logistique des intrants de santé, le Ministère de la Santé Publique, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, et dans le cadre de l'intégration des intrants de santé dans la chaîne nationale d'approvisionnement, a mis en place au niveau de la DPLMT, l'Unité Technique de Gestion Logistique (UTGL), qui sera chargée d'appuyer la gestion logistique de ces intrants de santé ; à savoir la maîtrise des différentes techniques de l'approvisionnement, l'estimation des besoins, l'exploitation des données logistiques, le suivi et la supervision, la coordination entre les différents intervenants dans le circuit logistique, le suivi et l'appui de toutes les activités de la chaîne d'approvisionnement au sein de l'ensemble du système logistique du pays.

Par la suite, l'élaboration du manuel de procédure logistique, qui entre dans le cadre de l'activité de l'UTGL, est plus qu'indispensable.

Ce "Manuel de procédures logistiques des intrants de santé" est destiné à tous les acteurs de la gestion logistique du système de santé dont l'objectif est de standardiser les outils de gestion à tous les niveaux, d'intégrer tous les programmes verticaux et d'harmoniser toutes les approches des partenaires techniques et financières (PTF) en se référant sur ce document de travail unique.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué techniquement et financièrement à l'élaboration de ce document de travail, et j'invite les agents de santé à l'utiliser.

Pour terminer, je souhaite plein succès au Ministère de la Santé Publique et à tous les PTF dans l'accomplissement de l'engagement pris pour l'amélioration de la santé de la population malagasy.

Le Ministre de la Santé Publique

Pr ANDRIAMANARIVO Mamy Lalatiana

Questions fréquemment posées

Questions	Réponses	
	Hôpitaux de référence, Hôpitaux spécialisés, Pha-G-Dis Hôpitaux des ONG agréées localisés à Antananarivo	CHRD I Pha-Ge-Com (CSB1) Pha-Ge-Com (CSB2) ONG agréées
A quelles dates / périodes faut-il passer les commandes pour éviter une rupture de stocks ?	Passez les commandes des intrants de santé au plus tard le 27 du mois suivant le trimestre (période de rapport)	Soumettez votre formulaire de « Rapport - Bon de Commande au plus tard le 15 du mois suivant la période de rapport
Comment calculer la quantité à commander (QàC) ?	Les calculs de la QàC sont faits automatiquement pour vous si vous utilisez CHANNEL . Imprimez le rapport-bon de commande. Si CHANNEL ne marche pas, Utilisez le formulaire « Rapport - Bon de Commande Trimestriel des Pha-G-Dis » à la page 33 ou « Rapport-Bon de Commande Trimestriel des Hôpitaux de Référence, des Hôpitaux Spécialisés et des Hôpitaux des ONG agréées localisés à Antananarivo » à la page 38. Suivez les instructions de remplissage de chacune des colonnes.	Utilisez le formulaire de « Rapport - Bon de commande des Pha-Ge-Com, ONG agréées et CHRD I » à la page 42. Suivez les instructions de remplissage de chacune des colonnes.
A quel moment doit-on passer une commande d'urgence (CU) ?	Quand le niveau de stock disponible et utilisable atteint ou est en-dessous de 2 mois de stock	Quand le niveau de stock disponible et utilisable atteint ou est en-dessous de 1 mois de stock.
Que faire en cas de rupture de stock ?	Passez une commande d'urgence à SALAMA ou à UASM.	Passez une commande d'urgence au Pha-G-Dis ou demander un transfert de stock d'une structure sanitaire voisine.
Comment savoir qu'un produit est périmé ?	Consultez les dates de péremption inscrites sur les emballages des intrants de santé. Un produit est périmé quand sa date de péremption est atteinte et/ou dépassée.	
Comment stocker correctement les Intrants de santé?	Pour les médicaments, utilisez la méthode « Premier Péréimé Premier Sorti (PPPS) » et respectez les principes d'un bon entreposage. Mettez à jour les fiches de stock.	

I. Introduction à la Logistique

But d'un système logistique : la règle des six bons

La mise en place des procédures de gestion logistique et des outils de collecte de données a pour but de satisfaire les besoins des clients des services de santé tout en mettant à leur disposition :

- Les Bons Intrants de santé
- En Bonne Quantité
- En Bonne Condition

Et qui soient disponibles

- Au Bon Endroit
- Au Bon Moment
- Au Bon Coût.

Sans un approvisionnement continu et fiable en médicaments et autres intrants de santé, la population perd la confiance aux services de santé. Des chaînes d'approvisionnement qui fonctionnent bien sont indispensables pour assurer une disponibilité régulière des Intrants de santé.

REMARQUE:

- Tous les six bons se valent et sont complémentaires, il n'y pas un qui soit plus important que l'autre.
- Le concept de bons Intrants de santé se réfère aussi bien aux Intrants de santé de bonne qualité qu'à leur variété.
- Le concept de bon coût ne fait pas seulement allusion au prix de vente aux clients (système de recouvrement des coûts) mais aussi aux dépenses liées à la gestion des Intrants de santé de santé.

Principales caractéristiques du système de gestion logistique des intrants de santé

Système d'approvisionnement

Le système d'approvisionnement des intrants de santé mis en place à Madagascar est un système de **réquisition**. Dans un système de réquisition, les quantités livrées sont déterminées par le personnel de la structure qui reçoit les intrants de santé.

Ainsi:

- Les gestionnaires / dispensateurs des Pha-Ge-Com (CSB1 et CSB2), des organisations non gouvernementales (ONG) agréées à but non lucratif, des CHRD1 déterminent les quantités des intrants de santé à commander auprès des pharmacies de gros du district – Pha-G-Dis.
- Les gestionnaires / pharmaciens / prestataires des Pha-G-Dis, des hôpitaux de référence, des hôpitaux spécialisés et les hôpitaux des ONG agréées localisés à Antananarivo déterminent les quantités des intrants de santé à commander auprès de SALAMA / UASM (Unité d'Approvisionnement en Soluté Massif).

Niveaux institutionnels de la chaîne d'approvisionnement et de distribution

La chaîne nationale d'approvisionnement et de distribution est composée de quatre (4) niveaux opérationnels qui sont :

- Le niveau central

Il est composé de la centrale d'achat des médicaments essentiels (SALAMA) et de l'unité d'approvisionnement de soluté massif (UASM)

 - SALAMA

Créée en 1996, la centrale d'achats des médicaments essentiels et de matériel médical, SALAMA, a pour mission principale d'approvisionner toutes les formations sanitaires publiques et privées à but non lucratif en médicaments essentiels génériques et consommables médicaux, de bonne qualité et à prix abordables. Elle a pour mission spécifique d'assurer:

 - le stockage et la gestion de tous les intrants de santé;
 - l'approvisionnement des Pharmacies de gros du district (Pha-G-Dis), des hôpitaux de référence, des hôpitaux spécialisés et des hôpitaux des ONG agréées localisés à Antananarivo.
 - UASM.

Elle a pour mission d'assurer :

 - le stockage et la gestion de tous les solutés massifs et alcools
 - l'approvisionnement des Pha-G-Dis, des hôpitaux de référence, des hôpitaux spécialisés et des hôpitaux des ONG agréées localisés à Antananarivo.
- Le niveau district (Pha-G-Dis), des hôpitaux de référence, des hôpitaux spécialisés et des hôpitaux des ONG agréées localisés à Antananarivo.
 - Pha-G-Dis.

Les prestataires de ses structures sont chargés :

 - du stockage et de la gestion des intrants de santé ;
 - de l'approvisionnement des Pharmacie à gestion communautaire (Pha-Ge-Com) i.e. les pharmacies des centres de santé de base de niveau 1 (CSB1) et celles des centres

de santé de base de niveau 2 (CSB2) ; des centres de santé des organisations non gouvernementales agréées à but non lucratif ; des hôpitaux de district (CHRD1).

- Hôpitaux de référence, hôpitaux spécialisés et hôpitaux des ONG agréées localisés à Antananarivo.

Les gestionnaires / pharmaciens / prestataires de ses structures sont chargés :

- du stockage et de la gestion des intrants de santé ;
- de la dispensation des intrants de santé aux clients.

- Le niveau CHRD1, CSB et ONG agréées à but non lucratif

Les gestionnaires et dispensateurs des pharmacies de ses structures sont chargés :

- du stockage et de la gestion des intrants de santé ;
- de la dispensation des intrants de santé aux clients.

- Le niveau communautaire

À ce niveau, nous avons les agents de santé communautaire. La gestion des intrants de santé

Au niveau communautaire n'est pas prise en compte dans le présent manuel. Elle nécessite des analyses complémentaires et approfondies pour mieux cerner ce dont les agents de santé communautaire ont besoin.

La Figure1 ci-dessous est une illustration du flux des intrants de santé et de l'information de la chaîne nationale de distribution des intrants de santé à Madagascar. Les intrants de santé vont des magasins centraux de SALAMA ou de UASM aux magasins des hôpitaux de référence, des hôpitaux spécialisés, des hôpitaux des ONG agréées localisés à Antananarivo et des Pha-G-Dis; ensuite des magasins des Pha-G-Dis, les intrants de santé sont livrés aux Pha-Ge-Com des CSB1 et CSB2, aux pharmacies des centres de santé des ONG agréées à but non lucratif et aux pharmacies des CHRD1. Les intrants de santé sont directement mis à la disposition des clients dans les centres de prestations de services cliniques.

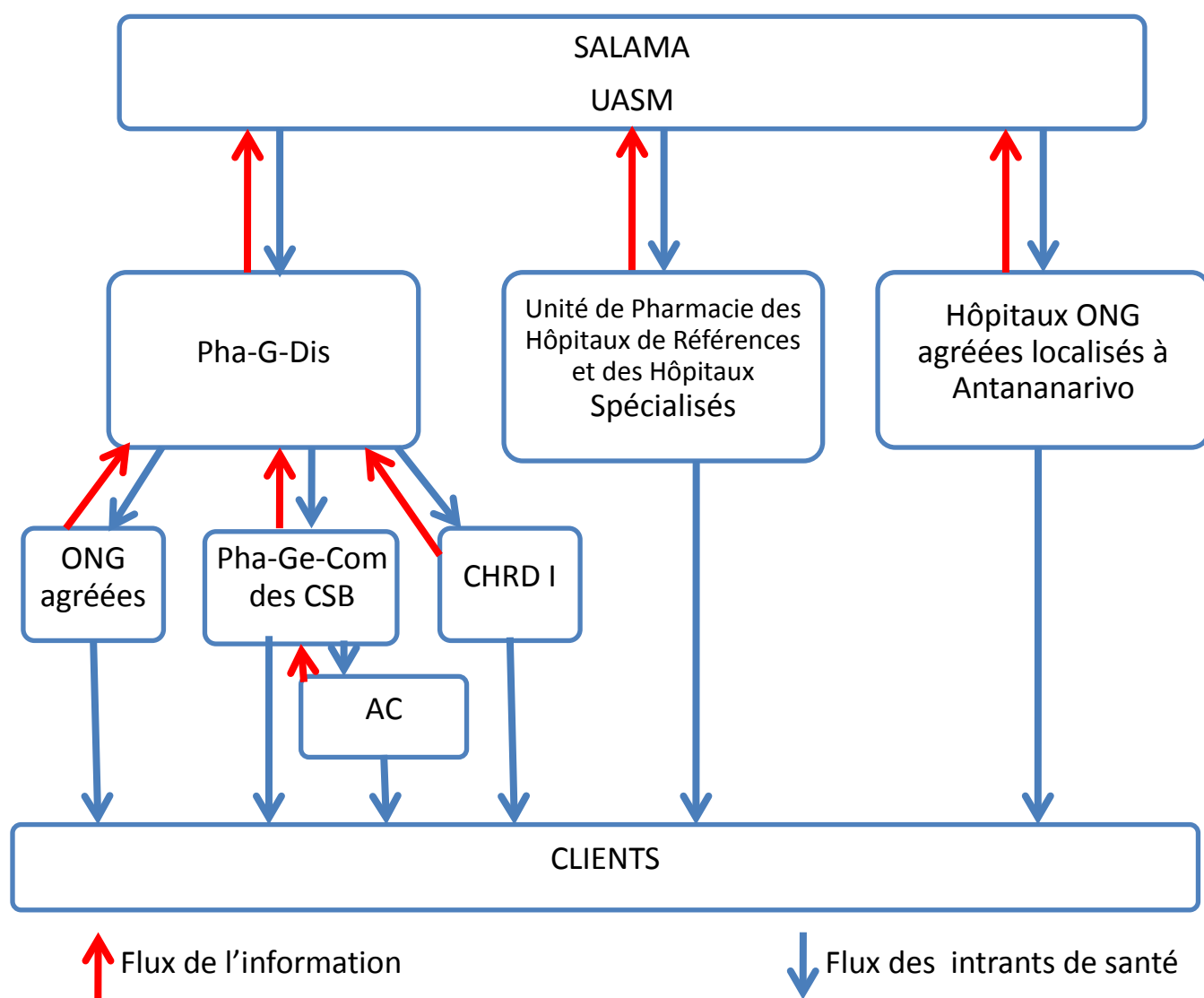
En retour, les Pha-Ge-Com, les pharmacies des centres de santé des ONG agréées, et celles des CHRD1 soumettent leurs formulaires de « Rapport – Bon de Commande » aux Pha-G-Dis. Les formulaires de « Rapport – Bon de Commande » contiennent les données essentielles de gestion logistique (données de consommation ; pertes et ajustement ; et stocks disponibles et utilisables) permettant de les réapprovisionner après soumission dudit rapport. Chaque district consolide dans CHANNEL les données des formations sanitaires qui sont sous sa juridiction.

Les pharmacies des hôpitaux de référence, des hôpitaux spécialisés, des hôpitaux des ONG agréées localisés à Antananarivo et les Pha-G-Dis, dès la saisie de leurs mouvements de stock dans CHANNEL, transmettent leur base de données à l'unité technique de gestion logistique pour consolidation dans la base de données centrale. Une fois consolidées, ces données seront accessibles à SALAMA et à UASM pour consultation et utilisation éventuelle. Le réapprovisionnement des hôpitaux de référence, des hôpitaux spécialisés, des hôpitaux des ONG agréées localisées à

Antananarivo et des Pha-G-Dis se fait sur présentation du bon de commande généré par CHANNEL ou du rapport – Bon de Commande correspondant.

Ensuite, l'unité technique de gestion logistique disséminera les données agrégées aux programmes respectifs. L'unité technique de gestion logistique préparera aussi des rapports de retro-information pour les institutions du niveau intermédiaire et du niveau périphériques si nécessaires. Les rapports de rétro-information devront être utilisés par le personnel du niveau central et du district pour des prises de décisions telles que l'organisation et la réalisation des activités de supervision.

Figure 1. Chaîne Nationale de Distribution des Intrants de Santé et Flux de l'Information



II. Rôles et Responsabilités du Personnel Impliqué dans la Gestion des Intrants de Santé

Beaucoup d'agents de santé jouent un rôle primordial dans le fonctionnement de la chaîne nationale de distribution des intrants de santé. Un résumé des rôles et responsabilités de ces personnes est repris dans le tableau ci-dessous. En fonction de votre travail ou rôle dans la chaîne nationale de distribution, ce manuel de procédures vous aidera à accomplir vos responsabilités à temps et de manière efficace.

- Si vous gérez au quotidien les intrants de santé, prière de chercher votre titre et les tâches correspondantes à vos responsabilités dans le tableau qui suit. Cela vous aidera à comprendre vos responsabilités en rapport avec le fonctionnement de la chaîne nationale de distribution des intrants de santé.
- Si aucun rôle ou responsabilité n'est assigné à un personnel de votre structure sanitaire, vous devez définir ses responsabilités de telle sorte que le personnel en question aie connaissance de ce qu'il doit faire afin de contribuer de manière efficace au meilleur fonctionnement de la chaîne de distribution et assurer ainsi que des quantités adéquates de intrants de santé soient disponibles pour les clients.
- Si vous supervisez un personnel qui gère les intrants de santé, il faut utiliser cette description de rôles et responsabilités pour vous assurer que le personnel en charge a une bonne compréhension de ses attributions et qu'il effectue le travail qui lui a été assigné.
- Si vous êtes une ONG ou un partenaire d'exécution, votre rôle et responsabilité dans la gestion des intrants peuvent varier en fonction d'un accord de collaboration entre le ministère de la santé publique et votre organisation. Dans tous les cas, referez-vous à la description des tâches de votre personnel.

Tableau 1. Rôles et Responsabilités

Niveau	Personnel	Rôles et Responsabilités
Unité Technique de Gestion Logistique / Comité Technique Logistique	Responsable du suivi et évaluation	- Assurer le développement, la mise en œuvre du système de suivi et d'évaluation de la chaîne logistique au niveau national et apporter un appui technique aux programmes à cette fin, - Participer et gérer les activités de collecte, de traitement, d'analyses, et de gestion des données, - Procéder à une évaluation de la qualité des données (EQD), - Contribuer à la prise en compte des recommandations des activités de suivi et d'évaluation afin d'améliorer le système, - Assurer le suivi de l'état du stock national, - Assurer le suivi de CHANNEL, Pipeline, ou autre logiciel, au niveau national (expéditions, reçus, commandes), - Assurer le suivi des indicateurs de performance logistique, - Présenter aux parties prenantes et autres partenaires les résultats intermédiaires et finaux des activités de suivi/évaluation ainsi que les recommandations afin d'améliorer le système, - Communiquer périodiquement les résultats de suivi du système logistique, - Planifier et mener les évaluations sur l'impact du système logistique des intrants de santé - Participer aux réunions du Comité National de lutte contre les ventes illicites de médicaments. - Assurer la documentation et la diffusion des meilleurs pratiques en gestion logistique. - Effectuer toute autre fonction, selon les besoins - Communiquer avec le ministère de la santé et les donateurs pour l'acquisition intrants de santé
SALAMA / UASM	Responsable des intrants de santé des programmes	- Superviser la gestion des intrants à SALAMA / UASM - Réceptionner les intrants de santé - S'assurer que les outils de gestion des stocks sont mis à jour à chaque réception ou expédition des intrants de santé - Veiller à l'application des principes de bon stockage - Préparer les commandes faites par les programmes et assurer leur distribution. - Rendre compte mensuellement du niveau de stock des intrants de santé de programmes

Niveau	Personnel	Rôles et Responsabilités	
	Responsable de la gestion des stocks et de la distribution	- En se référant aux bons de commande et aux données de CHANNEL, livrer les intrants de santé aux hôpitaux de référence, hôpitaux spécialisés, hôpitaux des ONG agréées localisés à Antananarivo et Pha-G-Dis - Suivre les niveaux de stock et évaluer périodiquement le système de distribution. - S'assurer que les outils de gestion des stocks sont mis à jour à chaque réception ou expédition des intrants de santé - Veiller à l'application des principes de bon stockage - Coordonner, en fonction du calendrier de distribution des intrants de santé, la distribution des intrants de santé - Suivre les expéditions des intrants de santé aux hôpitaux de référence, hôpitaux spécialisés, des hôpitaux des ONG agréées localisés à Antananarivo et Pha-G-Dis	
Pha-G-Dis	Prestataire	Rapport	- Vérifier les calculs des rapports reçus et corriger les éventuelles erreurs. - Saisir les données des CSB1, CSB2, ONG agréées et du CHRDI dans CHANNEL - Saisir les mouvements de stock de la Pha-G-Dis dans CHANNEL - Soumettre un rapport mensuel au Médecin Inspecteur (MI) ; Responsables de programmes et UTGL sur les mouvements de stock du district - Soumettre un état des ventes ainsi que l'état financier de la Pha-G-Dis au MI. - Soumettre au MI le rapport définitif de condamnation sur les intrants voués à la destruction
		Approvisionnement et Réception	- Assurer la réception provisoire et définitive des intrants de santé livrés par SALAMA / UASM - Inspecter les cartons reçus. Procéder à une inspection visuelle des intrants de santé et signer le bordereau de livraison - Ranger les intrants de santé reçus selon les principes d'un bon stockage - Mettre à jour et remplir correctement les outils de gestion des stocks - Enlever et isoler immédiatement les intrants de santé périmés ou avariés - Participer à l'inventaire physique mensuel des intrants de santé le dernier jour ouvrable du mois - Assurer la propreté du lieu de stockage

Niveau	Personnel	Rôles et Responsabilités	
		Distribution et Gestion	- Emballer, préparer et mettre à disposition des responsables de CSB1, de CSB2, d'ONG / Institutions agréées, du CHRD1 les intrants de santé - Honorer les commandes d'urgence - Aviser l'administration pour les médicaments en voie de péremption - Assurer le classement des archives et des outils de gestion de façon chronologique - Préparer la commande dans le système de gestion électronique pour permettre au MI de voir, analyser et approuver la commande automatiquement - En l'absence de système de gestion électronique transmettre le «Rapport – Bon de Commandes » au MI tous les trimestres pour validation et transmission à SALAMA
Hôpitaux de référence / Hôpitaux spécialisés / des Hôpitaux des ONG agréées localisés à Antananarivo	Prestataire/Pharmacien hospitalier	Rapport	- Saisir les mouvements de stock dans CHANNEL - Soumettre un rapport trimestriel à SALAMA et à l'UTGL sur les mouvements de stock
		Approvisionnement et Réception	- Participer à la réception provisoire et définitive des intrants de santé livrés par SALAMA / UASM - Inspecter les cartons reçus. Procéder à une inspection visuelle des intrants de santé et signer le bordereau de livraison - Ranger les intrants de santé reçus selon les principes d'un bon stockage - Mettre à jour et remplir correctement les outils de gestion des stocks - Enlever et isoler immédiatement les intrants de santé périmés ou avariés - Participer à l'inventaire physique mensuel des intrants de santé le dernier jour ouvrable du mois
		Dispensation et Gestion	Remplir le RUMER (cahier des activités journalières) à partir du pré RUMER
PhaGeCom / ONG / CHRD1	Chef CSB	Rapport	- Rédiger et soumettre le formulaire de « Rapport-Bon de Commande » au MI tous les deux mois - Viser les bons de commande

Niveau	Personnel	Rôles et Responsabilités	
		Approvisionnement	• Viser les bons de commande • Compiler la commande des AC • Intégrer les commandes des AC dans la commande de CSB
	CoGe	Approvisionnement et Réception	• Réceptionner les intrants de santé commandés pour la Pha-Ge-Com • Inspecter les cartons reçus. Procéder à une inspection visuelle des intrants de santé et signer le bordereau de livraison • Assurer la réception provisoire et définitive des intrants de santé livrés par la Pha-G-Dis • Enregistrer l'entrée en stock des intrants de santé • Veuille au rangement les intrants de santé reçus selon les principes d'un bon stockage • Veiller à la mise à jour et au remplissage correct des outils de gestion des stocks • Envoyer la commande transmise par le CSB à la Pha-G-Dis • Récupérer les intrants de santé commandés auprès de la Pha-G-Dis • Enlever et isoler immédiatement les intrants de santé périmés ou avariés
	Dispensateur	Dispensation et Gestion	• Etablir la commande des médicaments vers la pharmacie de gros • Gérer la pharmacie de détail • Délivrer les intrants de santé prescrits sur ordonnances • Expliquer au client l'utilisation de médicaments • Remplir régulièrement le RUMER • Percevoir les recettes générées par la vente des produits • Verser les recettes au Trésorier • Classer et archiver les souches des ordonnances factures • Participer avec le CoGe à l'inventaire physique mensuel des intrants de santé le dernier jour ouvrable du mois

III. Système d'Information de Gestion Logistique

Le but d'un Système d'Information de Gestion Logistique (SIGL) est de collecter, organiser, analyser, traiter et soumettre les données logistiques à tous les niveaux du système pour une prise de décision en gestion des intrants de santé.

Seule l'information qui aidera à la prise de décision devra être collectée. Trois types de données dites essentielles sont requis pour faire fonctionner une chaîne d'approvisionnement. Ces données sont :

- Le Stock Disponible Utilisable : Quantité d'intrants de santé utilisable disponible à un moment donné.
- La Consommation: Quantité d'intrants de santé distribuée aux clients pendant une période donnée.
- Les Pertes et Ajustements: Les pertes sont des quantités d'intrants de santé retirées de votre stock pour une raison autre que la distribution aux clients et non transférées à un autre centre. Il peut s'agir d'intrants de santé périmés, volés, endommagés, etc. Les ajustements sont des quantités d'intrants de santé reçues ou livrées à une structure de même niveau. Un ajustement peut être négatif (-) ou positif (+). Ces intrants de santé viennent en déduction (cas des pertes et/ou des intrants de santé transférés ou prêtés à un district ou un centre de santé voisin) ou en ajout du stock disponible (cas des intrants de santé reçus d'un district ou d'un centre de santé voisin).

Un SIGL bien structuré a des supports qui collectent les trois données essentielles ci-dessus énumérées.

Le système de gestion logistique des intrants de santé mis en place à Madagascar définit par niveau les formulaires de collecte de données à utiliser. Ces formulaires sont présentés l'un après l'autre dans les sections suivantes. Chaque formulaire est précédé d'un aide-mémoire qui décrit étape par étape le processus de son remplissage.

L'aide-mémoire est un outil qui vous aide à remplir correctement chaque support. Il servira de guide pour le remplissage des différentes parties du support.

Les supports de collecte de données

Plusieurs supports de collecte de données sont utilisés pour la gestion courante des médicaments. Ces supports ont été développés et mis à la disposition des structures sanitaires. Cependant, pour la gestion des intrants de santé, les supports ci-dessous énumérés sont les plus recommandés.

Tableau 2. Liste des supports par niveau

Central (SALAMA / UASM)
Fiche de stock
Rapport d'inventaire
Bon de livraison et de transfert des intrants de santé
Procès-verbal de réception définitive (PVRD)
Rapport d'inventaire des intrants de santé à détruire
Procès-verbal de destruction
Pha-G-Dis
Fiche de stock
Rapport d'inventaire
Bon de livraison et de transfert des intrants de santé
Procès-verbal de réception définitive (PVRD)
Rapport - Bon de Commande des Pha-G-Dis
Rapport d'inventaire des intrants de santé à détruire
Procès-verbal de destruction
Livre de caisse
Livre de banque
Hôpitaux de référence, Hôpitaux spécialisés, Hôpitaux des ONG agréées
Fiche de stock
Rapport d'inventaire
Bon de livraison et de transfert des intrants de santé
Procès-verbal de réception définitive (PVRD)
RUMER
Rapport - Bon de commande des Hôpitaux de référence, Hôpitaux spécialisés,
Rapport d'inventaire des intrants de santé à détruire
Procès-verbal de destruction
Livre de caisse
Livre de banque
Pha-Ge-Com (CSB1, CSB2), ONG Agréées, CHRDI
Fiche de stock
Rapport d'inventaire
Bon de livraison et de transfert des intrants de santé
Procès-verbal de réception définitive (PVRD)
RUMER
Rapport - Bon de Commande des Pha-Ge-Com, ONG Agréées, CHRDI
Rapport d'inventaire des Intrants de santé à détruire
Procès-verbal de destruction
Livre de caisse
Livre de banque

Les Aide-Memoires

Fiche de Stock

Tâche :		Remplir une fiche de stock	
Effectuée par :		- Le responsable des magasins de SALAMA et d'UASM - Le Prestataire de la Pha-G-Dis - Le Prestataire de la pharmacie de l'hôpital - Le Pharmacien de l'Unité de la Pharmacie - Le dispensateur / Chef CSB (Pha-Ge-Com)	
Objectifs :		- Enregistrer les entrées et les sorties des intrants de santé - Déterminer les consommations/distributions - Enregistrer les résultats d'inventaire physique	
Quand :		- Entrée et/ou sortie des intrants de santé - Sortie d'intrants pour avarie, péremption et/ou dommage - Enregistrement du résultat d'un inventaire physique : mettre en rouge toutes les informations relatives à l'inventaire	
Note :		Tenir une fiche de stock par marque / présentation du produit - A chaque mouvement, il faut remplir chaque colonne. - A chaque changement de fiche de stock, reporter la quantité de la fiche de stock précédente sur la ligne report (ne pas remplir les colonnes grisées). - Eviter les ratures, gommages, surcharges. Dans le cas contraire écrire « Je dis bien... » et signer. - La fiche de stock doit toujours accompagner chaque produit.	
Etapes	Parties à remplir	Notes	Exemples
1.	Site	Inscrire le nom de la structure / formation sanitaire qui stocke les intrants de santé.	Pha-G-Dis Mahajanga I
2.	Programme	Inscrire le nom du programme qui est bénéficiaire des intrants de santé.	FANOME
3.	Désignation, Forme et Dosage	Indiquer la dénomination commune internationale (DCI) ou la dénomination commerciale du produit ; se référer à la LNMEIS. La DCI est suivi immédiatement de la forme qui est la présentation pharmaceutique du médicament (comprimé, gélule, sirop, suspension buvable, pommade, etc.) et du dosage qui est la quantité de chaque principe ou ingrédient actif qui compose le médicament. Cette quantité peut être exprimée en milligrammes (mg), grammes (g), concentration (%), etc.	Cotrimoxazole 240 mg susp. buv.
4.	Unité	Il s'agit de l'unité de comptage. Elle est la plus petite unité de sortie du produit	Flacon
5.	Niveau de stock maximum	Indiquer le niveau de stock maximum de votre formation sanitaire. Reférez-vous à la page 52	03

6.	Niveau de stock minimum	Indiquer le niveau de stock minimum de votre formation sanitaire. Reférez-vous à la page 52	06
7.	Consommation Moyenne Mensuelle	A la fin de chaque mois, calculer et noter votre Consommation Moyenne Mensuelle (CMM) au crayon. La CMM peut changer avec chaque consommation. Si la consommation augmente ou baisse significativement d'un mois à un autre, il ne faut plus utiliser la CMM dans le calcul de la Quantité à Commander. Il est souhaitable de se référer à la consommation du dernier mois et l'utiliser comme « CMM ».	
8.	Date	Inscrire la date de chaque opération d'entrée ou de sortie des intrants de santé. Si un même produit est reçu ou livré avec différents numéros de lot et dates de péremption, utiliser une ligne pour chaque lot en précisant toujours la date de réception et la quantité correspondante.	10/09/15
9.	Origine/Destination	Indiquer le nom de la structure qui livre les intrants de santé ou le nom de celle qui les reçoit.	REPORT
10.	Date de péremption	La date de péremption peut être obtenue sur l'emballage ou la notice accompagnant chaque produit. Différents lots des intrants de santé peuvent avoir des dates de péremption différentes. Tout intrant de santé en voie de péremption (date de péremption $\leq$ 6 mois) et/ou en sur stockage au niveau du magasin est à redéployer.	05/17
11.	N° de lot	Le numéro de lot du médicament se trouve sur l'emballage (boîte ; carton ; plaquette etc.). Si le même produit a deux ou plusieurs numéros de lots différents, enregistrer chaque lot et la quantité correspondante sur la même fiche stock.	BPB9408A BPB9409A
12.	Entrées	Enregistrer la quantité de chaque produit reçu. Cette quantité doit être exprimée en unité de comptage. Les ajustements positifs (quantité reçue d'un autre site et/ou retrouvée après inventaire physique) seront enregistrés comme « Entrées » avec un commentaire dans la colonne « Observation ».	
13.	Sorties	Enregistrer la quantité de chaque produit livré ou	

		sorti du magasin. Cette quantité doit être exprimée en unité de comptage. Les intrants de santé périmés, détériorés ou qui ne sont plus utilisables doivent être isolés et sortis du stock. Inscrire les quantités correspondantes dans la colonne « Sorties » avec un commentaire dans la colonne « Observation ».	
14.	Stock	Indiquer le stock disponible après chaque opération d'entrée ou de sortie des intrants de santé. Il est calculé en faisant la différence entre les entrées et les sorties. Les intrants de santé endommagés, périmés sont à retirer du stock. Ils seront ensuite isolés pour destruction selon les procédures en vigueur.	240
15.	Observation	Inscrire dans cette colonne toute information utile relative aux entrées et aux sorties des intrants de santé.	

Fiche de Stock

Site : [Pha-G-Dis Mahajanga I](#)

Programme : **FANOME**

Désignation Forme et Dosage: **Cotrimoxazole**
susp.buv. 240mg

Niveau de Stock Minimum : 3

Niveau de Stock Maximum : 6

Unité: **Flacon** Consommation Moyenne Mensuelle :

Consommation Moyenne Mensuelle :

Mois de Stock Disponible :

[illegible]

Rapport d'Inventaire Physique

Tâche :	Remplir le formulaire de rapport d'inventaire physique		
Effectuée par :	- Le responsable des magasins de SALAMA et d'UASM - Le Prestataire de la Pha-G-Dis - Le Prestataire de la pharmacie de l'hôpital - Le Pharmacien de l'Unité de la Pharmacie - Le dispensateur / Chef CSB (Pha-Ge-Com)		
Objectifs :	- Déterminer la quantité des intrants de santé disponibles en stock - Déterminer la valeur du stock physique - Déterminer les écarts entre le stock théorique (solde de la fiche de stock) et le stock physique (résultat de l'inventaire)		
Quand :	- Au dernier jour ouvrable du mois - A la préparation d'une commande - Au moment de l'audit et/ou de l'inspection.		
Note :	- Avant l'exercice d'inventaire, il faut: - Ranger les intrants de santé par DCI et date de péremption selon le principe premier périmé, premier sorti. Les intrants de santé périmés doivent être retirés et isolés. - Mettre les fiches de stock à jour - Le rapport d'inventaire est imprimé en 3 copies auto-carbonées de couleur blanche, verte et rose. CSB : - Copie blanche remise au point focal CHANNEL du district - Copie verte et rose servent de souche Pha-G-Dis, hôpitaux de référence, hôpitaux spécialisés, hôpitaux des ONG agréées localisés à Antananarivo - Copie blanche remise au point focal CHANNEL du district / de l'hôpital - Copie verte remise au point focal CHANNEL de la région - Copie Rose sert de souche.		
Etapes	Parties à remplir	Notes	Exemples
1.	Région	Inscrire le nom de la Région	Boeny
2.	District	Inscrire le nom du District	Mahajanga I
3.	Site	Inscrire le nom de la structure / formation sanitaire où sont gérés les intrants.	Pha-G-Dis Mahajanga I
4.	Date	Inscrire la date de l'inventaire physique.	29/02/16
5.	Désignation, Forme et Dosage	Indiquer la dénomination commune internationale (DCI) ou la dénomination commerciale du produit ; se référer à la LNMEIS. La DCI est suivi immédiatement de la forme qui est la présentation pharmaceutique du médicament (comprimé, gélule, sirop, suspension buvable, pommade, etc.) et du dosage qui est la quantité de chaque principe ou ingrédient actif qui compose le médicament. Cette quantité peut être exprimée en milligrammes (mg), grammes (g), concentration (%), etc.	Amoxicilline susp.buv. 250mg/5ml

6.	Unité	Il s'agit de l'unité de comptage. Elle est la plus petite unité de sortie du produit	flacon
7.	Péremption	La date de péremption peut être obtenue sur l'emballage ou la notice accompagnant chaque produit. Différents lots du même produit peuvent avoir des dates de péremption différentes. Tout intrant de santé en voie de péremption (date de péremption $\leq$ 6 mois) et/ou en sur stockage au niveau du magasin est à redéployer.	01/07/18
8.	N° du lot	Le numéro de lot du médicament se trouve sur l'emballage (boîte, carton, plaquette etc.). Si le même produit a deux ou plusieurs numéros de lots différents, enregistrer chaque lot et la quantité correspondante sur le formulaire de rapport d'inventaire.	150710
9.	Quantité théorique	Il s'agit du solde de la fiche de stock à la date de l'inventaire physique.	2200
10.	Quantité physique	Aussi appelée « stock physique/stock réel », elle représente la quantité des intrants de santé disponibles et utilisables qui sont effectivement en stock. Le stock disponible et utilisable est obtenu en faisant un inventaire physique. Il ne prend pas en compte les intrants de santé endommagés, périmés, etc. ces derniers sont à retirer du stock et à isoler pour destruction selon les procédures en vigueur. Reporter, le même jour, le résultat de l'inventaire physique sur la fiche de stock et à l'encre rouge. Si vous avez plusieurs lots du même produit, comptez-les séparément, additionnez les chiffres obtenus pour avoir le total du stock physique.	2200
11.	Prix unitaire (MGA)	C'est le prix de vente par unité du produit.	1750
12.	Ecart	Faire la différence entre le stock compté et le stock théorique (solde de la fiche de stock) à la date de l'inventaire. Ecart = Stock physique – Stock théorique Si le résultat est positif, enregistrer la quantité obtenue dans la colonne entrée de la fiche de stock. Si le résultat est négatif, enregistrer la quantité obtenue dans la colonne sortie de la fiche de stock.	0
13.	Justification	Indiquer les raisons des écarts constatés si elles sont connues	
14.	Montant (MGA)	Calculer coût de chaque produit en stock en multipliant la quantité physique par le prix unitaire de vente correspondant.	3 850 000
15.	Montant Total	Faire la somme des coûts de tous les intrants de santé en stock pour obtenir le montant total.	3 982 000
16.	Signatures	Le rapport d'inventaire doit être signé par toutes les parties ayant participé à l'exercice d'inventaire physique.	

Rapport d'Inventaire Physique									
Région de :Boeny		District de : Mahajanga I			Site : Pha-G-Dis Mahajanga I		Date : 29 fév. 2016		
Désignation, Forme et Dosage	Unité	Date de péremption	N° de Lot	Quantité Théorique	Quantité Physique	Prix Unitaire (MGA)	Ecart	Justification	Montant (MGA)
Amoxicilline susp.buv. 250mg/5ml	flacon	07/2018	I50710	2200	2200	1750	0		3 850 000
Ocytocine sol. inj 10UI/ml	ampoule	03/2018	I50365	600	600	220	0		132 000
Depo-provera	flacon	09/2018	A08943	2050	2050	0	0		0
Montant total									3 982 000

Nom et signatures :

Bon de Livraison et de Transfert des Intrants de Santé

Tâche :	Remplir le bon de livraison et de transfert des intrants de santé.		
Effectuée par :	- Le responsable des magasins de SALAMA et d'UASM - Le Prestataire de la Pha-G-Dis - Le Prestataire de la pharmacie de l'hôpital - Le Pharmacien de l'Unité de la Pharmacie - Le dispensateur / Chef CSB (Pha-Ge-Com)		
Objectif :	Etablir une liste des intrants de santé livrés à une structure/ formation sanitaire		
Quand :	A chaque livraison des intrants de santé		
Note :	- Le bon de livraison et de transfert des intrants de santé est accompagné de la liste de colisage (à partir de SALAMA/UASM), de la facture, du relevé de situation pour FANOME. - Il est imprimé en trois copies auto-carbonées de couleur blanche, verte et rose : - Copie blanche remise au destinataire. - Copies verte et rose restent dans le carnet et servent de souche. - Une livraison non conforme doit être constatée et rapportée immédiatement c'est-à-dire dans les 72 heures ouvrables au fournisseur.		
Etapes	Parties à remplir	Notes	Exemples
1.	Site	Inscrire le nom de la structure / formation sanitaire qui recevra les intrants de santé.	CSB II Amborovy
2.	Date de livraison	Inscrire la date de la livraison.	08/12/15
3.	N° de Rapport-Bon de Commande	Ecrire le numéro d'ordre /séquentiel tel qu'il figure sur le rapport-bon de commande émis par la formation sanitaire.	01643
4.	N° Bon de Livraison/transfert	Le numéro du bon de livraison et de transfert des intrants de santé doit être séquentiel. Un feuillet raturé ou inutilisable doit rester dans le carnet du bon de livraison.	01659
5.	Type de transfert	En cas de transfert des intrants de santé, cocher la case « Retour des intrants de santé » ou la case « Redéploiement »	
6.	Désignation, Forme et Dosage	Indiquer la dénomination commune internationale (DCI) ou la dénomination commerciale du produit ; se référer à la LNMEIS. La DCI est suivi immédiatement de la forme qui est la présentation pharmaceutique du médicament (comprimé, gélule, sirop, suspension buvable, pommade, etc.) et du dosage qui est la quantité de chaque principe ou ingrédient actif qui compose le médicament. Cette quantité peut être exprimée en milligrammes (mg), grammes (g), concentration (%), etc.	Amoxicilline susp.buv. 250mg/ml
7.	Date de péremption (mois-année)	La date de péremption peut être obtenue sur l'emballage ou la notice accompagnant chaque produit. Différents lots des Intrants de santé peuvent avoir des dates de péremption différentes.	03/2017

		Tout intrant de santé en voie de péremption (date de péremption $\leq$ 6 mois) et/ou en sur stockage au niveau du magasin est à redéployer.	
8.	N° de Lot	Le numéro de lot du médicament se trouve sur l'emballage (boîte, carton, plaquette, etc.). Si le même produit a deux ou plusieurs numéros de lots différents, lister chacun des lots différemment.	140303
9.	Unité	Il s'agit de l'unité de comptage. Elle est la plus petite unité de sortie du produit	Flacon
10.	Quantité commandée	Noter le chiffre de la quantité commandée qui figure sur le rapport-bon de commande.	342
11.	Quantité livrée	Inscrire la quantité des Intrants de santé livrée à la formation sanitaire.	340
12.	Prix Unitaire (MGA)	Inscrire le prix de vente par unité du produit.	1300
13.	Montant	Calculer coût de chaque produit livré en multipliant la quantité par le prix unitaire correspondant.	442 000
14.	Programme	Inscrire le nom du programme qui est bénéficiaire des Intrants de santé.	FANOME
15.	Montant total	Faire la somme de la colonne « Montant » pour obtenir le montant total.	442 000
16.	Arrêté le présent bon de livraison et de transfert à articles	Indiquer le nombre total d'articles/intrants de santé livrés.	3
17.	A la somme de	Indiquer en toute lettre le montant total (en MGA) des intrants de santé livrés.	Quatre cent quarante-deux mille
18.	Nom et signature du Remettant	L'agent qui livre les intrants de santé inscrit son nom et appose sa signature.	
19.	Nom et signature du bénéficiaire	L'agent qui reçoit les intrants de santé inscrit son nom et appose sa signature.	

BON DE LIVRAISON ET/OU DE TRANSFERT DES INTRANTS DE SANTÉ <i>(Rayer la mention inutile)</i>								
Site : CSB II Amborovy								
Date de Livraison : 08/12/2015								
N° de Rapport-bon de commande : 01643								
N° Bon de Livraison : 01659								
Type de transfert : / Retour de intrants de santé / Redéploiement								
Désignation, Forme et Dosage	Date de péremption (mois-année)	N° de Lot	Unité	Quantité commandée	Quantité livrée	P.U	Montant	Programme
Amoxicilline susp.buv. 250mg/5ml	03/2017	140303	Flacon	342	340	1 300	442 000	FANOME
Depo-provera	09/2018	A08943	Dose	387	375	0	0	PF
Sulfadoxyne/Pyrimethamine Comp. 500mg/2 5mg	11/2017	4L24	Comp.	1 065	1 065	0	0	Paludisme
MONTANT TOTAL							442 000	
Arrêté le présent Bon de Livraison à 03 articles,								
à la somme de : Quatre cent quarante-deux mille							MGA	
Nom et Signature du Remettant					Nom et Signature du Bénéficiaire			

Procès - Verbal de Réception Définitive

Tâche :	Remplir le procès-verbal de réception définitive.		
Effectuée par :	• Le Prestataire de la Pha-G-Dis • Le Prestataire de la pharmacie de l'hôpital • Le Responsable de l'unité de la pharmacie • Le Chef du CSB		
Objectifs :	• Accuser réception des intrants de santé reçus • Vérifier la conformité des intrants de santé livrés aux quantités commandées.		
Quand :	Au plus tard 72 heures après la livraison des intrants de santé		
Note :	• Le Procès-verbal de réception définitive n'est valable que s'il est bien rempli et dûment signé. • Il est imprimé en quatre (4) copies auto-carbonées de couleur blanche, bleue, verte et rose : CSB - Copie blanche remise au prestataire de la Pha-G-Dis. - Copie Bleue remise à SDSP - Copies verte et rose restent dans le carnet et servent de souche Pha-G-Dis, hôpitaux de référence, hôpitaux spécialisés, hôpitaux des ONGs agréées (localisées à Antananarivo) - Copie blanche remise à SALAMA / USAM - Copie bleue remise à DPLMT - Copie verte remise à la DRSP - Copie rose reste dans le carnet et sert de souche		
Étapes	Parties à remplir	Notes	Exemples
1.	Site	Inscrire le nom de la structure/formation sanitaire qui a reçu les intrants de santé.	Pha-G-Dis Mahajanga I
2.	Date de livraison	Inscrire la date à laquelle les intrants de santé ont été reçus à la formation sanitaire.	22/02/2016
3.	N° de Rapport-Bon de Commande	Inscrire le numéro du Rapport-Bon de Commande.	
4.	N° de Bon de livraison/transfert	Inscrire le numéro du Bon de Livraison/transfert des intrants de santé.	L1600786 L1600541
5.	Fournisseur	Indiquer le nom de la structure qui livre les intrants de santé.	SALAMA
6.	Désignation, Forme et Dosage	Indiquer la dénomination commune internationale (DCI) ou la dénomination commerciale du produit ; se référer à la LNMEIS. La DCI est suivi immédiatement de la forme qui est la présentation pharmaceutique du médicament (comprimé, gélule, sirop, suspension buvable, pommade, etc.) et du dosage qui est la quantité de chaque principe ou ingrédient actif qui compose le médicament. Cette quantité peut être exprimée en milligrammes (mg), grammes (g), concentration (%), etc.	Amoxicilline susp.buv. 250mg/5ml

7.	Date de péremption (mois-année)	La date de péremption peut être obtenue sur l'emballage ou la notice accompagnant chaque produit. Différents lots des Intrants de santé peuvent avoir des dates de péremption différentes. Tout intrant de santé en voie de péremption (date de péremption $\leq$ 6 mois) et/ou en sur stockage au niveau du magasin est à redéployer.	07/2018
8.	N° de lot :	Le numéro de lot du médicament se trouve sur l'emballage (boîte ; carton ; plaquette etc.). Si le même produit a deux ou plusieurs numéros de lots différents, lister chacun des lots différemment.	150710
9.	Unité	Il s'agit de l'unité de comptage. Elle est la plus petite unité de sortie du produit au niveau des formations sanitaires.	Flacon
10.	Quantité reçue	Inscrire la quantité de chaque marque de produit reçue (par unité de comptage).	2860
11.	Prix Unitaire (MGA):	Indiquer le prix à l'achat par unité du produit.	1750
12.	Montant	Calculer coût de chaque produit livré en multipliant la quantité par le prix unitaire correspondant.	5 005 000
13.	Programme	Inscrire le nom du programme qui est bénéficiaire des intrants de santé.	FANOME
14.	Observations	Inscrire dans cette colonne toute information utile relative aux intrants de santé reçus. Indiquer les résultats de l'inspection visuelle, les éventuels écarts entre la commande et la livraison, etc.	
15.	Montant total	Faire la somme des coûts de tous les reçus pour obtenir le montant total.	5 915 000
16.	Date de Réception de la commande	Indiquer la date à laquelle la réception définitive des intrants de santé a été faite.	22/02/2016
17.	Signatures des membres du comité de réception	Les membres du comité de réception inscrivent individuellement leur nom et signent le procès-verbal de réception définitive.	

PROCES – VERBAL DE RECEPTION DEFINITIVE

Site : [Pha-G-Dis Mahajanga I](#)

Date de Livraison : [22/02/2016](#)

N ° de Rapport-Bon de Commande :

N° Bon de Livraison/Transfert des Intrants de Santé : [LI600786 – LI600541](#)

Fournisseur : [SALAMA](#)

Nous membres du comité de réception soussignés avons procédé à la réception définitive des Intrants de santé suivants:

Désignation, Forme et Dosage	Date de péremption (mois- année)	N° de Lot	Unité	Quantité reçue	P.U (MGA)	Montant (MGA)	Programme	Observations
Amoxicilline susp.buv. 250mg/5ml	07/2018	150710	Flacon	2860	1750	5 005 000	FANOME	
Ocytocine sol. inj 10UI/ml	03/2018	150365	Ampoule	700	220	154 000	FANOME	
Gentamycine inj. 80mg	08/2019	150831	Ampoule	5400	140	756 000	FANOME	
MONTANT TOTAL						5 915 000		

Date de Réception de la commande : [22/02/2016](#)

Registre d'Utilisation des Médicaments et Recettes journalières (RUMER)

Tâche :	Remplir le RUMER		
Effectuée par :	- Le Dispensateur de la Pha-Ge-Com - Le Vendeur de l'unité de pharmacie de l'hôpital.		
Objectifs :	- Enregistrer quotidiennement la quantité des intrants de santé distribuée aux clients - Enregistrer, si nécessaire, les recettes générées et les versements effectués auprès du Trésorier.		
Quand :	A la fin de chaque journée.		
Note :	- Les ordonnances factures, bons de soins, carnets à souche servent de pièces justificatives de l'utilisation des intrants de santé. Ils doivent être conservés précieusement pour audit et contrôle. - Les produits de programme doivent être inclus dans le RUMER avec valeur zéro (0) dans la colonne recette		
Etapes	Parties à remplir	Notes	Exemples
1.	Formation sanitaire	Indiquer le nom de la formation sanitaire.	CSB II Amborovy
2.	Mois de:	Indiquer le mois en cours.	Février 2016
3.	Désignation, Forme et Dosage	Indiquer la dénomination commune internationale (DCI) ou la dénomination commerciale du produit ; se référer à la LNMEIS. La DCI est suivi immédiatement de la forme qui est la présentation pharmaceutique du médicament (comprimé, gélule, sirop, suspension buvable, pommade, etc.) et du dosage qui est la quantité de chaque principe ou ingrédient actif qui compose le médicament. Cette quantité peut être exprimée en milligrammes (mg), grammes (g), concentration (%), etc.	Amoxicilline susp.buv. 250mg/5ml
4.	Stock Initial (A):	C'est la quantité des intrants de santé disponibles et utilisables à la fin du mois précédent. Il est aussi le résultat de l'inventaire physique.	09
5.	Entrées (B) :	Inscrire les quantités des intrants de santé reçues au cours du mois.	120
6.	Total disponible (C)	Faire le calcul suivant C = A + B . Le résultat représente la quantité totale de chaque produit qui était disponible à la formation sanitaire pendant le mois.	129

7.	Sorties journalières (colonne I à 31)	Inscrire la quantité totale de chaque marque de produit distribuée aux clients à la fin de chaque journée. Si il n'y a pas eu distribution au cours de la journée, marquer zéro .	2-1-5-7-14-13-5-3-5-1-5-1-4-5-1-10-5-7-5-5-10
8.	Sortie totale (D)	Pour chaque marque de produit donné, faire la somme des distributions journalières (du premier au dernier jour du mois).	114
9.	Stock final théorique (E):	Pour chaque marque de produit, calculer le stock final théorique à la fin du mois. Il s'obtient en faisant la différence entre Total disponible (Col. C) et Sortie Totale (Col. D) i.e. = C – D	15
10.	Stock réel à l'inventaire (F):	Cette quantité est obtenue après inventaire physique du stock disponible auprès du dispensateur ou du vendeur au dernier jour du mois.	15
11.	Ecart (G) :	C'est la différence observée entre le stock théorique et le stock réel i.e. G = F – E	0
12.	Recette	Inscrire le montant de la recette journalière (MGA).	208 700– 160 000- 200 800- 146 400-122 200
13.	Versement:	Indiquer le montant versé au trésorier du CoGe ou au caissier de l'hôpital. Les sommes versées doivent être égales aux recettes générées (MGA).	310 700
14.	Emargement dispensateur	Le dispensateur appose sa signature après chaque opération de versement. Cette signature est obligatoire.	
15.	Emargement trésorier	Le trésorier ou le caissier appose également sa signature pour confirmer chaque versement reçu. Cette signature est obligatoire	
16.	Observation	Expliquer les écarts obtenus.	
17.	Total du mois :	Faire la somme des recettes journalières générées au cours du mois. Cette somme doit être égale à la somme des versements effectués(MGA).	3 574 150
18.	Contrôle du :	Indiquer la date du contrôle effectué par le responsable de la formation sanitaire.	
19.	Signature :	Le contrôleur appose sa signature. Cette signature est obligatoire.	

REGISTRE D'UTILISATION DES MEDICAMENTS ET RECETTES JOURNALIERES

Mois de : **Février 2016**

Désignation, forme et dosage	A	B	C	SORTIES JOURNALIERES														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Amoxicilline susp.buv. 250mg/5ml</i>	9	120	129	2	1	5	7	14	0	0	13	5	3	5	1	0	0	5
<i>Sulfadoxine/Pyriméthamine comprimé 500mg/25mg</i>	92	947	2039	45	12	60	33	33	0	0	63	9	27	15	15	0	0	48
Observations	Recettes perçues au cours de la journée			3500	1750	8750	12250	24500	0	0	22750	8750	5250	8750	1750	0	0	8750
	Versement			3500	1750	8750	12250	24500	0	0	22750	8750	5250	8750	1750	0	0	8750
	Emargements Dispensateur Trésorier																	

SORTIES JOURNALIERES																			
16	17	18	19	20	21	22	23	23	25	26	27	28	29	30	31	D	E	F	G
1	4	5	1	0	0	0	10	5	7	5	5	0	10			114	15	15	
30	26	0	69	0	0	27	9	18	0	33	0	0	54			636	403	403	
1750	7000	8750	1750	0	0	0	17500	8750	12250	8750	8750	0	17500			Total mois	199 500 ariary		
1750	7000	8750	1750	0	0	0	17500	8750	12250	8750	8750	0	17500				Contrôle du Date Signature		

(A) = Stock initial

(B) = Entrées au cours du mois

(C = A+B) = Total disponible du mois

(D) = Sortie totale du mois

(E = C-D) = Stock final théorique du mois

(F) = Stock réel après inventaire

(G=E-F) = Ecart

Rapports – Bons de Commande

a. Rapport-Bon de Commande Trimestriel des Pha-G-Dis

Tâche :	Remplir le Rapport-Bon de Commande Trimestriel des Pha-G-Dis		
Effectuée par :	Le Prestataire de la Pha-G-Dis, Responsable FANOME et Point Focal Channel		
Objectifs :	• Rapporter l'utilisation des quantités des intrants de santé reçus • Rapporter l'état de stock de la pharmacie • Déterminer la quantité des intrants de santé à commander • Passer la commande des intrants de santé		
Quand :	A la fin de chaque trimestre et le 27 du mois suivant la période du rapport ou en cas de commande d'urgence		
Note :	• Le rapport est à remplir si CHANNEL ne fonctionne pas • Il est imprimé en quatre (4) copies de couleur blanche, bleue, verte et rose : - Copie blanche remise à SALAMA /UASM - Copie bleue remise au SGIS/DPLMT (à récupérer à SALAMA) - Copie verte remise au DRSP - Copie rose reste dans le carnet et sert de souche		
Etapes	Parties à remplir	Notes	Exemples
1.	Région	Inscrire le nom de la région sanitaire	Boeny
2.	District	Inscrire le nom du district sanitaire	Mahajanga I
3.	Pha-G-Dis	Inscrire le nom de la Pha-G-Dis	Pha-G-Dis Mahajanga I
4.	Année	Inscrire l'année	2015
5.	Mois	Inscrire les mois concernés par le trimestre	Sept-Oct.-Nov.
6.	Code	Identification du produit suivant la nomenclature de SALAMA	06210102ANCIP
7.	Désignation, Forme et Dosage	Indiquer la dénomination commune internationale (DCI) ou la dénomination commerciale du produit ; se référer à la LNMEIS. La DCI est suivi immédiatement de la forme qui est la présentation pharmaceutique du médicament (comprimé, gélule, sirop, suspension buvable, pommade, etc.) et du dosage qui est la quantité de chaque principe ou ingrédient actif qui compose le médicament. Cette quantité peut être exprimée en milligrammes (mg), grammes (g), concentration (%), etc.	Amoxicilline, susp. buv. 250mg/5ml
8.	Unité	Il s'agit de l'unité de comptage. Elle est la plus petite unité de sortie du produit	flacon

9.	Quantités disponibles en début du trimestre	Inscrire la quantité totale de chaque produit disponible à la pharmacie en début du trimestre. Ce chiffre est égal à la quantité disponible au premier jour du trimestre à la pharmacie. Cette quantité doit être égale à celle notée dans la colonne H du rapport du trimestre précédent	1400
10.	Quantités reçues au cours du trimestre	Inscrire la quantité totale de chaque produit reçu au cours du trimestre. Les quantités reçues sont obtenues à partir des fiches de stock si elles sont à jour ou des bordereaux de livraisons de SALAMA /UASM et/ou autres fournisseurs	1000
11.	Quantités distribuées aux clients au cours du trimestre	Inscrire la quantité totale de chaque produit livré aux Pha-Ge-Com, ONG Agréées et CHRDI. Les quantités distribuées peuvent être obtenues à partir des fiches de stock si elles sont à jour. Pour chaque produit, additionner pour le trimestre correspondant, les quantités de la colonne « Sorties »	1740
12.	Quantités perdues au cours du trimestre	Pour chaque intrant, inscrire le total des pertes enregistrées au cours du trimestre Les intrants de santé volés, endommagés, périmés, etc. sont considérés comme des pertes	0
13.	Quantités restantes en fin de trimestre	Inscrire la quantité de chaque intrant disponible au dernier jour du trimestre. Ces quantités sont obtenues après un inventaire physique des stocks de la pharmacie. Si les mouvements de stock sont corrects, on obtient le même chiffre en faisant le calcul suivant: H = D + E - F - G	660
14.	Consommation ajustée des CSB, CS des ONG et des CHRDI du district	Les Pha-Ge-Com des CSB, les ONG Agréées et les CHRDI produisent un rapport tous les deux mois. Additionner les consommations ajustées de chaque intrant des rapports de toutes les structures rapportant au Pha-G-Dis. La consommation ajustée se trouve dans la « colonne I » du rapport - bon de commande des Pha-Ge-Com – ONG agréées – CHRDI .	2077
15.	Stock Maximum	Calculer et noter la quantité maximale du Pha-G-Dis. Pour chaque intrant, multiplier la « consommation ajustée » (col. I) par le chiffre trois (3) i.e. J = I x 3	6231
16.	Quantité à commander	Calculer et noter la quantité à commander pour chaque intrant. La quantité à commander est égale à la différence positive entre le « Stock Maximum » (col. J) et le « Stock restant en fin de trimestre » (col.	5571

		H) : K = J - H Si le résultat de cette opération est négatif ou égal à zéro, vous avez suffisamment d'intrants de santé. Vous n'avez rien à commander. Inscrire zéro dans la colonne K « quantités à commander »	
17.	Quantité à commander (arrondie au conditionnement)	Ramener les quantités à commander au conditionnement de SALAMA	5571
18.	Prix Unitaire TTC en MGA par conditionnement	Indiquer le prix d'achat par conditionnement fourni par SALAMA. Ceci est valable uniquement pour les intrants FANOME.	1750
19.	Montant	Multiplier la quantité à commander (arrondie au conditionnement de SALAMA) par le prix d'achat unitaire TTC (en MGA) par conditionnement de SALAMA. Soit N=L*M	9 749 250
20.	Total	Inscrire la somme des montants de la colonne N	9 918 450
21.	Commentaires	Noter toute observation jugée nécessaire pour la compréhension des chiffres communiqués et du rapport.	
22.	Date	Inscrire la date d'établissement du rapport-bon de commande Pha-G-Dis	26 Novembre 2015
23.	Nom et Signature du Prestataire de la Pha-G-Dis	Le Prestataire inscrit son nom et signe le rapport-bon de commande avant de l'envoyer au responsable FANOME	
24.	Nom et signature du Responsable FANOME	Le Responsable FANOME, après vérification, inscrit son nom et signe le rapport-bon de commande avant de l'envoyer au Médecin Inspecteur.	
25.	Nom et Signature du Médecin Inspecteur	Le Médecin Inspecteur, après avoir vérifié tous les calculs, inscrit son nom et contresigne le rapport. Sa signature engage sa responsabilité.	

**REPUBLIQUE DE MADAGASCAR –
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE**

Région de: **Boeny**

Année: **2015**

District de:
Mahajanga I

Pha-G-Dis de: **Mahajanga I**

Mois: **Sept-Oct-Nov**

RAPPORT - BON DE COMMANDE TRIMESTRIEL DE LA PHA-G-DIS

Rapport									Commande				
Code	Désignation, Forme et Dosage	Unité	Quantités disponibles en début du trimestre	Quantités reçues au cours du trimestre	Quantités distribuées aux clients au cours du trimestre	Quantités perdues au cours du trimestre	Quantités restantes en fin de trimestre	Consommation ajustée des CSB, CS des ONG et des CHRD I du district	Stock Maximum	Quantité à commander	Quantité commandée (arrondie au conditionne- ment)	Prix Unitaire TTC en MGA par conditionnement	Montant
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
							H=D+E-F-G		J=I* 3	K=J-H			N=L*M
06210102ANCIP	Amoxicilline susp. buv. 250mg/5ml	Flacon	1400	1000	1740	0	660	2077	6231	5571	5571	1750	9 749 250
06220804ANAIP	Cotrimoxazole comp. 400mg/- 80mg	Comp.	800	1000	1500	0	300	1300	3900	3600	36	4700	169 200
									TOTAL				9 918 450
Commentaires:									Date : 26 Novembre 2015				
Nom et Signature du Prestataire de la Pha-G-Dis				Noms et signatures du Responsable FANOME et/ou Point Focal Channel					Nom et Signature du Médecin Inspecteur				

b. Rapport-Bon de Commande Trimestriel des Hôpitaux de Référence, Hôpitaux Spécialisés, Hôpitaux des ONG agréées localisés à Antananarivo

Tâche :	Remplir le Rapport – Bon de Commande Trimestriel des Hôpitaux de Référence, Hôpitaux Spécialisés, hôpitaux des ONG agréées localisés à Antananarivo		
Effectuée par :	- Le Prestataire de la pharmacie de l'hôpital - Le Pharmacien de l'unité de pharmacie		
Objectifs :	- Rendre compte de l'utilisation des quantités des intrants de santé reçus - Rendre compte de l'état de stock de la pharmacie - Déterminer la quantité des intrants de santé à commander - Passer la commande des intrants de santé		
Quand :	A la fin de chaque trimestre et le 27 du mois suivant la période du rapport ou en cas de commande d'urgence		
Note :	- Le rapport est à remplir si CHANNEL ne fonctionne pas - Il est imprimé en quatre (4) copies de couleur blanche, bleue, verte et rose : - Copie blanche remise à SALAMA /UASM - Copie bleue remise au SGIS/DPLMT (à récupérer à SALAMA) - Copie verte remise au DRSP - Copie rose reste dans le carnet et sert de souche		
Etapes	Parties à remplir	Notes	Exemples
1.	Région de :	Inscrire le nom de la région sanitaire	Boeny
2.	District de :	Inscrire le nom du district sanitaire	Mahajanga I
3.	Hôpital de Référence / Hôpital Spécialisé de :	Encerclez le type d'hôpital et inscrire son nom	CHU Androva
4.	Trimestre	Inscrire les mois concernés par le trimestre	Sept-Oct.-Nov. 2015
5.	Code	Identification du produit suivant la nomenclature de SALAMA	06210102ANCIP
6.	Désignation, Forme et Dosage	Indiquer la dénomination commune internationale (DCI) ou la dénomination commerciale du produit ; se référer à la LNMEIS. La DCI est suivi immédiatement de la forme qui est la présentation pharmaceutique du médicament (comprimé, gélule, sirop, suspension buvable, pommade, etc.) et du dosage qui est la quantité de chaque principe ou ingrédient actif qui compose le médicament. Cette quantité peut être exprimée en milligrammes (mg), grammes (g), concentration (%), etc.	Amoxicilline, susp.buv. 250mg/5ml
7.	Unité	Il s'agit de l'unité de comptage. Elle est la plus petite unité de sortie du produit	Flacon
8.	Quantités disponibles en début du trimestre	Inscrire la quantité totale de chaque intrant disponible à la pharmacie en début du trimestre. Ce chiffre est égal à la quantité disponible au premier jour du trimestre à la pharmacie.	276

		Cette quantité doit être égale à celle notée dans la colonne H du rapport trimestriel précédent	
9.	Quantités reçues au cours du trimestre	Inscrire la quantité totale de chaque produit reçu au cours du trimestre. Les quantités reçues sont obtenues à partir des fiches de stock si elles sont à jour ou des bordereaux de livraisons de SALAMA /UASM et/ou autres fournisseurs	193
10.	Quantités distribuées aux clients au cours du trimestre	Inscrire la quantité totale de chaque intrant livré aux clients. Les quantités distribuées peuvent être obtenues à partir des fiches de stock si elles sont à jour. Pour chaque intrant, additionner pour le trimestre correspondant, les quantités de la colonne « Sorties »	253
11.	Quantités perdues au cours du trimestre	Pour chaque intrant, inscrire le total des pertes enregistrées au cours du trimestre. Les intrants de santé volés, endommagés, périmés, etc. sont considérés comme des pertes	0
12.	Quantités restantes en fin de trimestre	Inscrire la quantité de chaque intrant disponible au dernier jour du trimestre Ces quantités sont obtenues après un inventaire physique des stocks de la pharmacie. Si les mouvements de stock sont corrects, on obtient le même chiffre en faisant le calcul suivant: H=D+E-G-H	216
13.	Nombre de jours de rupture de stock	Inscrire le nombre de jours de rupture de stock de chaque intrant. Le nombre de jours de rupture de stock est le nombre de jours couvrant la période où la formation sanitaire ne dispose plus de quantité suffisante pour servir les clients jusqu'au jour où elle reçoit une livraison des intrants concernés. Le nombre de jours de rupture de stock peut s'obtenir à partir des fiches de stock	0
14.	Nombre de jours de service sans rupture de stock	Calculer le nombre de jours de service sans rupture de stock pour chaque intrant. Utiliser la formule suivante: J = 91,5 - I	91,5
15.	Consommation trimestrielle ajustée	Calculer la consommation trimestrielle ajustée (trois derniers mois écoulés). Multiplier les consommations de la colonne F par 91,5 et diviser par les chiffres de la colonne J et. Soit la formule : K = [F*91,5]/J	253
16.	Stock Maximum	Calculer et noter la quantité maximale de l'hôpital de référence ou de l'hôpital spécialisé. Pour chaque intrant, multiplier la « consommation ajustée » (col. K) par 2 : L = K x 2	506

17.	Quantité à commander	Calculer et noter la quantité à commander pour chaque intrant La quantité à commander est égale à la différence positive entre le « Stock Maximum » (col. L) et le « Stock restant en fin de trimestre » (col. H) : $M = L - H$ Si le résultat de cette opération est négatif ou égal à zéro, vous avez suffisamment d'intrants de santé. Vous n'avez rien à commander. Inscrire zéro dans la colonne M « quantités à commander »	290
18.	Quantité commandée (arrondie au conditionnement)	Ramener les quantités à commander au conditionnement de SALAMA	290
19.	Prix Unitaire TTC en MGA par conditionnement	Indiquer le prix d'achat par conditionnement fourni par SALAMA. Ceci est valable uniquement pour les intrants FANOME.	1 750
20.	Montant	Multiplier la quantité à commander (arrondie au conditionnement de SALAMA) par le prix d'achat unitaire TTC (MGA) par conditionnement de SALAMA. Soit $P = N * O$	507 500
21.	Commentaires	Noter toute observation jugée nécessaire pour la compréhension des chiffres communiqués et du rapport.	
22.	Date	Inscrire la date de soumission du rapport-bon de commande de l'hôpital de référence ou de l'hôpital spécialisé.	30 Novembre 2015
23.	Nom et Signature du Prestataire ou gestionnaire de la pharmacie	Le Prestataire inscrit son nom et signe le rapport-bon de commande avant de l'envoyer Médecin Chef	
24.	Nom et Signature du Chef de l'établissement hospitalier	Le Chef de l'établissement hospitalier, après avoir vérifié tous les calculs, inscrit son nom et contresigne le rapport. Sa signature engage sa responsabilité.	

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Région de: [Boeny](#)

Année: [2015](#)

District de: [Mahajanga I](#)

Trimestre: [Sept – Oct.-Nov.](#)

Hôpital de référence / Etablissement Spécialisé de: [CHU Androva](#)

RAPPORT – BON DE COMMANDE TRIMESTRIEL DES HOPITAUX DE REFERENCE, HOPITAUX SPECIALISES, HOPITAUX DES ONGS AGREEES (localisés à Antananarivo)

RAPPORT											COMMANDE				
CODE	Désignation, Forme et Dosage	Unité	Quantités disponibles en début du trimestre	Quantités reçues au cours du trimestre	Quantités distribuées aux clients au cours du trimestre	Quantités perdues au cours du trimestre	Quantités restantes en fin de trimestre	Nombre de jours de rupture de stock	Nombre de jours de service sans rupture de stock	Consommation trimestrielle ajustée	Stock Maximum	Quantité à commander	Quantité commandée (arrondie au conditionnement)	Prix Unitaire TTC en Ariarypar conditionnement	Montant
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
							$H = D+E-F-G$		$J = 91,5 - I$	$K = [F*91,5]/J$	$L = K \times 2$	$M = L - H$			$P = N*O$
06210102ANCIP	Amoxicilline susp. buv. 250MG/5ML	Flacon	276	193	253	0	216	0	91,5	253	506	290	290	1750	507 500
18310402ANFIP	DepoProvera	Flacon	0	60	10	0	50	13	78,5	12	24	0	0	0	0

Commentaires:

Date: 30 Novembre 2015

Nom et Signature du Prestataire ou gestionnaire de la pharmacie :

Nom et Signature du Chef de l'établissement hospitalier :

c. Rapport – Bon de Commande des CSB1, CSB2 (Pha-Ge-Com), ONG agréées et CHRD1

Tâche :	Remplir le Rapport - Bon de Commande des CSB I, CSB2 (Pha-Ge-Com), ONG agréées, CHRD1		
Effectuée par :	• Le Dispensateur / Chef CSB • Le Gestionnaire de la pharmacie de l'ONG agréée, • Le Responsable de l'unité de pharmacie du CHRD1		
Objectifs :	• Rendre compte de l'utilisation des quantités des intrants de santé reçus • Rendre compte de l'état de stock de la pharmacie • Déterminer la quantité des intrants de santé à commander • Passer la commande des intrants de santé		
Quand :	Tous les deux mois		
Note :	Le rapport - bon de commande des CSB I, CSB2 (Pha-Ge-Com), ONG agréées, CHRD1 est imprimé en trois (3) copies auto-carbonées de couleur blanche, bleue et rose : - Copie blanche remise à la Pha-G-Dis - Copie bleue remise au responsable FANOME/Médecin Inspecteur du district - Copie rose reste dans le carnet et sert de souche		
Etapes	Parties à remplir	Notes	Exemples
1.	Région :	Indiquer le nom de la région sanitaire.	Boeny
2.	District :	Indiquer le nom du district sanitaire.	Mahajanga I
3.	CHRD1 :	Indiquer le nom de l'hôpital de district.	
4.	CSB ONG	Indiquer le nom du centre de santé de base ou de la formation sanitaire de l'ONG agréée.	CSB II Amborovy
5.	Date du rapport:	Inscrire la date à laquelle le présent rapport-bon de commande est soumis.	24/11/2015
6.	Mois couvert :	Indiquer les mois pris en compte pour le présent rapport-bon de commande.	Sept-Oct.
7.	Code	Identification du produit suivant la nomenclature de SALAMA	22100201ANF2P
8.	Désignation, Forme et Dosage	Indiquer la dénomination commune internationale (DCI) ou la dénomination commerciale du produit ; se référer à la LNMEIS. La DCI est suivi immédiatement de la forme qui est la présentation pharmaceutique du médicament (comprimé, gélule, sirop, suspension buvable, pommade, etc.) et du dosage qui est la quantité de chaque principe ou ingrédient actif qui compose le médicament. Cette quantité peut être exprimée en milligrammes (mg), grammes (g), concentration (%), etc.	Diazépam, Comp., 5mg
9.	Unité	Il s'agit de l'unité de comptage. Elle est la plus petite unité de sortie du produit	Comprimé (Cp)

10.	Quantités disponibles au début de la période	Inscrire la quantité totale de chaque intrant disponible à la pharmacie et au point de dispensation au premier jour du mois. Cette quantité doit être égale à celle notée dans la colonne H du rapport du trimestre précédent.	466
11.	Quantités reçues au cours de la période	Inscrire la quantité totale de chaque intrant reçu au cours des deux derniers mois. Les quantités reçues sont obtenues à partir des fiches de stock si elles sont à jour ou des bons de livraison et de transfert des intrants de santé des Pha-G-Dis et/ou autres fournisseurs.	0
12.	Quantités distribuées aux clients au cours de la période	Calculer et inscrire la quantité totale de chaque produit livré aux patients / clients. Les quantités distribuées sont obtenues à partir du RUMER. Pour chaque intrant, additionner les quantités des colonnes « Sortie Journalières » ou de la colonne D du RUMER.	67
13.	Quantités perdues au cours de la période / Ajustements	Pour chaque intrant, inscrire le total des pertes enregistrées au cours des deux derniers mois. Les intrants de santé volés, endommagés, périmés, etc. sont considérés comme des pertes.	0
14.	Quantités restantes en fin de période	Inscrire la quantité totale de chaque intrant disponible au dernier jour du deuxième mois. Ces quantités sont obtenues après un inventaire physique des stocks de la pharmacie et du point de dispensation des intrants de santé. Si les mouvements de stock sont corrects, on obtient le même chiffre en faisant le calcul suivant: H = D + E - F - G	399
12.	Nombre de jours de rupture de stock	Inscrire le nombre de jours de rupture de stock de chaque produit. Inscrire le nombre de jours de rupture de stock de chaque intrant. Le nombre de jours de rupture de stock est le nombre de jours couvrant la période où la formation sanitaire ne dispose plus de quantité suffisante pour servir les clients jusqu'au jour où elle reçoit une livraison des intrants concernés. Le nombre de jours de rupture de stock peut s'obtenir à partir des fiches de stock	0
13.	Nombre de jours de service sans rupture de stock	Pour chaque intrant, calculer le nombre de jours de service sans rupture de stock. Utiliser la formule suivante: J = 61 - I	61
14.	Consommation Ajustée de la période	Calculer la consommation ajustée des deux derniers mois écoulés. Diviser les consommations de la colonne F par les chiffres de la colonne J et multiplier par 61. Soit la formule : K = [F*61]/J	67

15.	Stock Maximum	Calculer et noter le stock maximum du CSB1, CSB2 (Pha-Ge-Com), de l'ONG agréées, du CHRDI Pour chaque produit, multiplier la « Consommation ajustée de la période » (col. K) par le chiffre deux (2) ce qui donne: $L = K * 2$	134
16.	Quantités commandées	La quantité à commander est égale à différence positive entre le Stock Maximum (col. L) et la Quantité Restante en fin de mois (col. H). Soit la formule : $M = L - H$	0
17.	Quantités livrées	Ce sont les quantités effectivement reçues de la Pha-G-Dis	
18.	Prix Unitaire TTC (MGA)	Indiquer le prix d'achat unitaire à la Pha-G-Dis. Ceci est valable uniquement pour les intrants FANOME.	88
19.	Montant	Multiplier la quantité livrée par le prix d'achat unitaire TTC (MGA). Soit la formule $P = N * O$	0
20.	Commentaires:	Noter tout commentaire jugé nécessaire pour la compréhension des chiffres communiqués et du rapport	
21.	Nom et Signature du Chef CSB /Médecin Chef du CHRDI	Le chef du CSB / Médecin Chef du CHRDI, après avoir vérifié tous les calculs, inscrit son nom et contresigne le rapport. Sa signature engage sa responsabilité	
22.	Nom et Signature du Dispensateur / Responsable de l'unité de pharmacie	Le Dispensateur / Responsable de l'unité de pharmacie signe le rapport-bon de commande avant de l'envoyer à son supérieur hiérarchique. Cette signature est obligatoire	
23.	Nom et Signature du Prestataire de la Pha-G-Dis	Le Prestataire de la Pha-G-Dis, dès réception du rapport-bon de commande et après vérification et livraison des intrants de santé, inscrit son nom et appose sa signature.	
24.	Nom et Signature de l'agent qui réceptionne les intrants de santé:	L'agent qui réceptionne les intrants de santé signe le rapport-bon de commande après réception des produits	
25.	Date de commande des intrants de santé	Inscrire la date de la commande	24/11/2015
26.	Date de livraison des intrants de santé	Inscrire la date de la livraison	
27.	Date de réception des intrants de santé	Inscrire la date de la réception	

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Région de: **Boeny**

District de: **Mahajanga**

CHRD I :

Date du rapport: **24/11/15**

CSB I :

Mois couvert: **Sept-oct.**

CSB II : **Amborovy**

ONG agréée :

Rapport											Commande				
Code	Désignation, Forme et Dosage	Unité	Quantités disponibles au début de période	Quantités reçues au cours de la période	Quantités distribuées aux clients au cours de la période	Quantités perdues au cours de la période / Ajustements	Quantités restantes en fin de période	Nombre de jours de rupture de stock	Nombre de jours de service sans rupture de stock	Consommation ajustée de la période	Stock Maximum	Quantité à commander	Quantités livrées	Prix Unitaire	Montant
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
							H=D+E-F-G		J=61-I	K=[F*61]/J	L = K*2	M = L - H			P = N*O
24300107ANAIP	Diazépam Comp. 5mg	Comp	466	0	67	0	399	0	61	67	134	0	0	88	0
18310402ANFIP	Acetate de Medroxyprogesterone, Inj - (Depo - Provera, Petogen)	Fl.	175	500	354	0	321	0	61	354	708	387	375	0	0

Commentaires:

Nom et Signature du Chef CSB ou du Médecin Chef du CHRD1	Nom et Signature du Dispensateur/Responsable de la pharmacie	Nom et Signature du Prestataire de la Pha-G-Dis	Nom et Signature de l'agent qui réceptionne les produits:
Date de commande des produits:		Date de livraison des produits:	Date de réception des produits:

Rapport d'Inventaire des Intrants de Santé à Détruire

Tâche :	Remplir le rapport d'inventaire des intrants de santé à détruire		
Effectuée par :	- Le Prestataire de laPha-G-Dis - Le Pharmacien/Responsable de l'unité de pharmacie de l'hôpital, - Le Dispensateur /Chef CSB		
Objectif :	Lister et valoriser les intrants de santé à détruire		
Quand :	Chaque fois qu'il y a des intrants de santé à détruire		
Note :	- Procéder à la destruction si la valeur des intrants de santé est plus de 100 000 MGA. - Ce rapport est généré par CHANNEL pour la Pha-G-Dis, l'hôpital de référence ou spécialisé et hôpitaux des ONG agréées localisés à Antananarivo. - Remplir le rapport d'inventaire des intrants de santé à détruire si CHANNEL ne fonctionne pas ou s'il n'est pas disponible du tout. - Une copie du rapport d'inventaire des intrants de santé périmés doit être annexée au PV de destruction des intrants de santé - Le rapport d'inventaire est imprimé en trois (3) copies auto-carbonées de couleur blanche, verte et rose : - Copie blanche remise au Médecin Inspecteur - Copie verte remise au membre du comité de destruction - Copie rose reste dans le carnet et sert de souche		
Etapes	Parties à remplir	Notes	Exemples
1.	Site	Inscrire le nom de la structure /formation sanitaire qui envisage de détruire les intrants de santé	Pha-G-Dis Mahajanga I
2.	Désignation, Forme et Dosage	Indiquer la dénomination commune internationale (DCI) ou la dénomination commerciale du produit ; se référer à la LNMEIS. La DCI est suivi immédiatement de la forme qui est la présentation pharmaceutique du médicament (comprimé, gélule, sirop, suspension buvable, pommade, etc.) et du dosage qui est la quantité de chaque principe ou ingrédient actif qui compose le médicament. Cette quantité peut être exprimée en milligrammes (mg), grammes (g), concentration (%), etc.	Amoxicillinesusp. buv. 250mg/5ml
3.	Unité	Il s'agit de l'unité de comptage. Elle est la plus petite unité de sortie du produit	Flacon
4.	Numéro de lot	Le numéro de lot du médicament se trouve sur l'emballage (boîte ; carton ; plaquette etc.). Si le même produit a deux ou plusieurs numéros de lots différents, enregistrer chaque lot sur la fiche stock	BPB9402A
5.	Programme	Préciser le nom du programme pour lequel les intrants de santé seront détruits	FANOME
6.	Date de péremption	Indiquer la date péremption des intrants à détruire. La date de péremption peut être obtenue sur l'emballage ou la	08/09/2015

		notice accompagnant chaque produit. Différents lots d'intrants de santé peuvent avoir des dates de péremption différentes	
7.	Quantité	Indiquer la quantité par DCI des intrants de santé à détruire	12
8.	Prix de Vente Unitaire (MGA)	Inscrire le prix de vente par unité de produit.	2 363
9.	Montant	Pour chaque intrant de santé, multiplier le prix unitaire par la quantité correspondante afin d'obtenir la valeur de chaque produit à détruire	28 356
10.	Montant total	Faire la somme des chiffres de la colonne « Montant » pour obtenir le montant total	28 356
11.	Date	Indiquer la date de l'établissement du rapport d'inventaire des produits à détruire	15 Février 2016
12.	Le Prestataire / Dispensateur	Indiquer le nom du Prestataire / Dispensateur qui a effectué l'inventaire. Il signe le rapport d'inventaire et appose le cachet de son service	
13.	Le Chef CSB / Chef de l'établissement	Le Chef CSB / Chef de l'établissement, après vérification, contresigne le rapport d'inventaire et appose le cachet du service	
14.	Autres membres de comité de destruction	Si l'inventaire est effectué en présence d'autres membres du comité de destruction, chaque membre signera le rapport d'inventaire des intrants de santé à détruire, apposera sa signature et le cachet du service	

Rapport d'Inventaire des Intrants de Santé à Détruire

Site:

Désignation, Forme et Dosage	Unité	Numéro de lot	Programme	Date de péréemption	Quantité	PU	Montant
Amoxicilline susp.buv. 250mg/5ml	Flacon	BPB9402A	FANOME	08/09/2015	12	2 363	28 356
					MONTANT TOTAL		28 356

Date : 15 Février 2016

Le Prestataire / Dispensateur

Nom et signature, cachet du service

Le Chef CSB / Chef de l'établissement

Nom et signature, cachet du service

Autres membres du comité de destruction

Nom et signature, cachet du service

Livre de caisse

Tâche :	Enregistrer les entrées et sorties d'argent de la caisse		
Effectuée par :	• Prestataire de la Pha-G-Dis • Responsable de l'unité de pharmacie • Trésorier de la Pha-Ge-Com		
Objectifs:	• Faire le suivi des mouvements de la caisse • Déterminer le solde de la caisse		
Quand :	A chaque mouvement de la caisse (entrées et sorties d'argent)		
Note :	• Le montant de la caisse ne doit pas dépasser 100 000 Ariary • Toute dépense doit être discutée et approuvée au préalable • Remplir correctement, lisiblement sans rature ni gommage, ni surcharge jusqu'à la dernière ligne de la page • Le contrôle de caisse se fait de façon inopinée • Le livre de caisse doit être côté et parafé par le chef hiérarchique.		
Etapes	Parties à remplir	Notes	Exemples
1.	Site	Inscrire le nom de la structure/formation sanitaire	
2.	Date de l'opération	Indiquer la date d'entrée ou de retrait d'argent de la caisse	
3.	Désignation de l'opération (Motifs d'utilisation)	Décrire les motifs d'utilisation de l'argent. Le libellé doit être clair, précis et sans ambiguïté	
4.	N° pièce justificative	Indiquer le numéro de la pièce justificative. Assurez-vous que toute facture relative à une dépense dispose d'un numéro de transaction	
5.	Crédit	Enregistrer dans cette colonne toute entrée de caisse. Les entrées doivent être équivalentes aux versements journaliers effectués	
6.	Débit	Enregistrer dans cette colonne toute sortie de la caisse.	
7.	Solde	Indiquer le montant restant de la caisse. Le solde ne peut pas être négatif.	
8.	Emargement	Le trésorier appose sa signature à chaque opération effectuée.	
9.	Report de solde	Inscrire le montant de la colonne « Solde à reporter » de la page précédente	
10.	Solde à reporter	Inscrire le montant du fonds de caisse.	

Site :

Solde à reporter

Livre de banque

Tâche :	Enregistrer chaque opération de versement et de retrait à la banque		
Effectuée par :	• Prestataire de la Pha-G-Dis • Responsable de l'unité de pharmacie • Trésorier de la Pha-Ge-Com		
Objectifs :	• Faire le suivi des opérations bancaires • Déterminer le solde de la banque		
Quand :	A chaque opération de versement ou de retrait de la banque		
Note :	• Les opérations de retrait ou de dépense doivent être approuvées au préalable • Remplir correctement, lisiblement sans rature ni gommage, ni surcharge de ligne jusqu'à la dernière page du livre de banque • A la fin de chaque mois, procéder à une réconciliation bancaire (confronter le solde du relevé bancaire au solde du livre de banque) • Le livre de banque doit être côté et parafé par le chef hiérarchique.		
Etapes	Parties à remplir	Notes	Exemples
1.	Site	Inscrire le nom de la structure/formation sanitaire	
2.	Nom de la Banque	Ecrire le nom de la banque	
3.	N° de compte bancaire	Ecrire le numéro du compte bancaire	
4.	Date de l'opération	Indiquer la date de versement ou de retrait à la banque	
5.	Désignation de l'opération (Motifs d'utilisation)	Décrire l'opération bancaire effectuée avec un libellé clair, précis et sans ambiguïté	
6.	N° de chèque bancaire	Ecrire le numéro du chèque bancaire. Ce numéro est séquentiel. Un chèque comportant des erreurs doit être annulé et doit rester agrafé dans le chéquier	
7.	N° pièce justificative	Indiquer le numéro de la pièce justificative. Assurez-vous que tout bordereau de versement, bordereau de retrait et/ou toute facture relative à une dépense effectuée dispose d'un numéro clairement lisible	
8.	Crédit	Enregistrer dans cette colonne toute opération de versement effectuée à la banque	
9.	Débit	Enregistrer dans cette colonne toute opération de retrait ou de dépense effectuée à la banque	
10.	Solde	A chaque opération, indiquer le solde bancaire.	
11.	Emargement	Le prestataire/trésorier ou son cosignataire appose sa signature à chaque opération effectuée.	
12.	Solde à reporter	Inscrire la balance de votre compte bancaire.	

Livre de banque

Site :

Banque							
N° de compte							
Date de l'opération	Désignation de l'opération (Motifs d'utilisation)	N° Chèque bancaire	N° pièce justificative	Crédit	Débit	Solde	Emargement
Solde à reporter							

IV. Le Système de Contrôle d'Inventaire

Le but d'un système de contrôle d'inventaire est de savoir quand commander et quelle quantité à commander pour maintenir un niveau de stock adéquat permettant de satisfaire les besoins des clients. Un bon système de contrôle d'inventaire aide à prévenir les ruptures de stock, les sur-stockages et à éviter la péremption des intrants de santé.

La commande forcée

Le système de contrôle d'inventaire mis en place est la « Commande Forcée ». C'est à dire que les Pha-Ge-Com, les pharmacies des centres de santé des ONG agréées et les pharmacies des CHRD1 passeront, auprès des Pha-G-Dis, la commande **de tous les intrants de santé** qu'ils gèrent tous les deux mois. Pour ce faire, ils soumettront leur «**Rapport - Bon de Commande** » avant d'être approvisionnés.

Les hôpitaux de référence, hôpitaux spécialisés, hôpitaux des ONG agréées localisés à Antananarivo et les Pha-G-Dis passeront la commande **de tous les intrants de santé** tous les trois mois et selon le calendrier de distribution de SALAMA.

Le tableau ci-dessous décrit le processus de préparation et de soumission de « Rapport – Bon de Commande » des formations sanitaires en vue d'un réapprovisionnement.

Tableau 3 : Soumission de « Rapport – Bon de Commande » des formations sanitaires

Structures	Qui prépare le rapport?	Qui approuve le rapport?	Qui reçoit le rapport?	Délai de soumission
Pha-Ge-Com (CSB1, CSB2)	Dispensateur, le Président du CoGe et le Chef CSB	Chef CSB et Président du CoGe	Chef du SDSP Responsable FANOME Prestataire de la Pha-G-Dis	Au plus tard le 15 du mois suivant la période de rapport ; la commande se fera tous les deux mois
ONG Agréées	Responsable logistique de l'ONG	Chef hiérarchique de l'ONG	Prestataire de la Pha-G-Dis Chef du SDSP	
Centre Hospitalier de Référence du District niveau 1	Responsable Unité de pharmacie	Chef de l'établissement Responsable FANOME	Prestataire de la Pha-G-Dis Chef du SDSP	
Centre Hospitalier de Référence du District niveau 2	Responsable de l'Unité de Pharmacie/Prestataire	Chef de l'établissement Responsable FANOME	DRSP, DPLMT, SALAMA	Au plus tard le 27 du mois suivant la période du rapport ; la commande se fera tous les trois mois.
Pha-G-Dis	Prestataire de la Pha-G-Dis	Chef SDSP Responsable FANOME Point Focal CHANNEL	DRSP, DPLMT, SALAMA	
Hôpital régional de référence	Pharmacien ou Responsable de l'Unité de Pharmacie ou Prestataire	Directeur de l'Etablissement /Pharmacien/ Responsable FANOME	DRSP, DPLMT, SALAMA	
Hôpital régional spécialisé	Pharmacien ou Responsable de l'Unité de Pharmacie ou Prestataire	Directeur de l'Etablissement /Pharmacien/ Responsable FANOME	DRSP, DPLMT, SALAMA	
Hôpitaux des ONG agréées localisés à Antananarivo	Pharmacien ou Responsable de l'Unité de Pharmacie ou Prestataire	Directeur de l'Etablissement /Pharmacien	DRSP, DPLMT, SALAMA	

A l'approvisionnement, tous les intrants de santé seront ramenés à leur niveau maximum.

Les niveaux de stock

Le tableau ci-dessous reprend les niveaux de stock minimum, maximum et point de commande d'urgence établis pour chaque structure/formation sanitaire de la chaîne nationale d'approvisionnement:

Tableau 4 : Niveaux de stock par catégorie de structure/formation sanitaire

Niveau institutionnel	Période de revue ou fréquence de réapprovisionnement (en mois)	Niveau minimum (en mois)	Niveau maximum (en mois)	Niveau de point de commande d'urgence (en mois)
SALAMA / UASM	4	9	13	6
Pha-G-Dis - Hôpital de référence - Hôpital spécialisé - Hôpitaux des ONG agréées localisés à Antananarivo	3	3	6	2
Pha-Ge-Com (CSB1 & CSB2) - ONG Agréées - CHRED	2	2	4	1

Evaluation de l'État de Stock

Un système de contrôle d'inventaire maximum / minimum est un système qui permet d'avoir des quantités qui oscillent entre un niveau maximum et un niveau minimum. Pour savoir si le niveau de stock se situe entre le minimum et le maximum, vous devriez évaluer l'état de votre stock ou encore calculer le nombre de mois de stock disponible.

Quand vous évaluez l'état de votre stock, vous cherchez à savoir quelle quantité d'intrants de Santé est en stock et *Combien de temps cette quantité durera*. Pour ce faire, vous procédez à un

inventaire physique des stocks disponibles et utilisables. Après comptage, vous allez avoir une quantité totale disponible. Ensuite, il est important de savoir si cette quantité des intrants de santé disponibles est suffisante pour couvrir les besoins des clients jusqu'à la prochaine livraison de la commande en cours ou à venir. Procéder à un tel exercice, c'est ce qu'on appelle déterminer le nombre de mois de stock disponible.

Le Mois de Stock Disponible (MSD) est le nombre de mois que durera un produit en tenant compte du taux de consommation actuel. 3 mois de stock disponible signifient que votre stock durera 3 mois, aussi longtemps que le taux de consommation actuel restera plus ou moins invariable.

Le calcul du MSD permet de déterminer si votre centre est sous-stocké, sur-stocké, ou stocké adéquatement c'est-à-dire stocké entre le minimum et le maximum. Si vous êtes en dessous de votre minimum (sous-stockés) et que votre commande en cours n'est pas en voie d'être livrée, vous devez placer une commande d'urgence. Si vous êtes au-dessus de votre maximum (sur-stocké) et qu'il y a risque de péremption, retournez le surplus de stock à votre magasin d'approvisionnement pour redistribution.

I. Comment Calculer le Mois de Stock Disponible

a) Calcul de la Consommation Moyenne Mensuelle

Calculer la Consommation Moyenne Mensuelle (CMM) c'est déterminer le niveau moyen de consommation des clients sur une période de temps donné.

La CMM est une donnée très importante pour la gestion des intrants de santé. Elle est utilisée pour calculer la quantité à commander et pour calculer les niveaux de stock disponible.

CSB, ONG agréées, CHRD I

Pour calculer la CMM des CSB, ONG agréées et CHRD1, suivez les étapes suivantes:

1. Prendre la consommation ajustées au nombre de jours de rupture de stock des deux (2) derniers mois
2. Diviser la consommation ajustée par deux (2).

D'où la formule:

$$\text{CMM} = \text{Consommation ajustées des 2 derniers mois} \div 2$$

Pha-G-Dis

La CMM de la Pha-G-Dis est égale à la somme des CMM des formations sanitaires qu'elle approvisionne.

D'où la formule:

$$\text{CMM} = \sum \text{CMM CSB} + \sum \text{CMM ONG agréées} + \text{CMM CHRD1}$$

Hôpitaux de référence, établissements spécialisés et hôpitaux des ONG agréées localisés à Antananarivo.

Pour calculer la CMM des Pharmacies des hôpitaux de référence, des hôpitaux spécialisés et des hôpitaux des ONGs agréées, suivez les étapes suivantes:

1. Prendre la consommation ajustée des trois (3) derniers mois
2. Diviser la consommation ajustée par trois (3).

D'où la formule:

$$\text{CMM} = \text{Consommation ajustée des 3 derniers mois} \div 3$$

b). Calcul du Mois de Stock Disponible (MSD)

Pour calculer le MSD, le gestionnaire des stocks devra suivre les 4 étapes suivantes:

3. Faire un inventaire physique des stocks disponibles et utilisables
4. Isoler les intrants de santé périmés, endommagés ou non utilisables
5. Déterminer la Consommation Moyenne Mensuelle (CMM) pour chaque intrant de santé (cf. section a). ci-dessus)
6. Diviser le stock disponible et utilisable par la CMM

D'où la formule:

MSD =	Stock Disponible et Utilisable
	CMM

2. Quand procéder à une évaluation de l'état des stocks

L'état de stock d'un magasin doit être évalué chaque fois que vous pensez que les niveaux de stock ne sont plus entre les niveaux maximum et minimum recommandés pour votre structure/formations sanitaire. Cette situation peut se produire si les intrants de santé sont endommagés, périmés, volés, ou si vous avez une hausse ou une baisse inattendue de la consommation.

Les districts devront évaluer l'état des stocks des centres de santé durant les visites de supervision et/ou pendant une visite de suivi de routine.

Commande des intrants de santé

Nous avons deux types de commandes: la commande systématique ou routinière et la commande d'urgence.

- La **commande systématique ou routinière** est effectuée à la fin de la période de revue :
 - tous les deux mois pour les Pha-Ge-Com, les ONG agréées et les CHRD1
 - tous les trois mois pour les Hôpitaux de référence, les hôpitaux spécialisés, les hôpitaux des ONG agréées localisés à Antananarivo et la Pha-G-Dis.
- La **commande d'urgence** est effectuée lorsque le niveau de stock disponible (MSD) est inférieur ou égal au niveau du seuil d'alerte (**point de commande d'urgence**).

a) Comment passer une commande?

Pour passer la commande, les **Pha-Ge-Com, ONG agréées et CHRD1** doivent remplir et soumettre leur formulaire de « **Rapport – Bon de Commande** » à la Pha-G-Dis.

Quant aux **hôpitaux de référence, hôpitaux spécialisés, hôpitaux des ONG agréées localisés à Antananarivo et Pha-G-Dis**, ils doivent générer le formulaire de commande de CHANNEL et le soumettre à SALAMA ou UASM pour approvisionnement. Si la base de données de CHANNEL est mise à jour, le rapport de mouvement de stock est automatiquement mis à jour, tous les calculs effectués et le formulaire de commande prêt à être imprimé. Cependant, si CHANNEL n'est pas fonctionnel pour une raison ou pour une autre, les **hôpitaux de référence, hôpitaux spécialisés, hôpitaux des ONG agréées localisés à Antananarivo et Pha-G-Dis** doivent utiliser les formulaires de **Rapport - Bon de Commande Trimestriel** respectifs.

Ces formulaires doivent être remplis **entièrement** et **correctement**. Des modèles desdits formulaires sont présentés et expliqués aux **pages 31 – 42** du présent manuel.

b) Calcul de la Quantité à Commander (QAC)

Commander la bonne quantité d'intrants de santé, c'est commander une quantité qui permet d'éviter à la fois les ruptures de stock et les sur-stockages. Cette quantité est déterminée en prenant en compte les paramètres suivants :

- ✓ L'intervalle de commande,
- ✓ Le niveau de stock maximum,
- ✓ Le stock disponible et utilisable.

L'intervalle de commande ou encore période de revue définit la périodicité de la commande. Les Pha-Ge-Com, ONG agréées et CHRD1 passeront une commande tous les deux mois. Les hôpitaux de référence, hôpitaux spécialisés et Pha-G-Dis passeront les leurs tous les trois mois.

Le calcul de la Quantité à Commander passe par les 5 étapes suivantes :

7. Calculer la **CMM**
8. Déterminer le **Stock Maximum** (SM)
9. **SM = CMM x Niveau Maximum**
10. Déterminer le **Stock Disponible et Utilisable (SDU)**
11. Soustraire du **Stock Maximum** le **Stock Disponible et Utilisable**
12. Vérifier **vos calculs**

D'où la formule:

$$\text{QàC} = (\text{Quantité du Stock Maximum}) - (\text{Stock Disponible et Utilisable})$$

Ou encore :

$$\text{QàC} = (\text{CMM} \times \text{Niveau du Stock Maximum}) - (\text{Stock Disponible et Utilisable})$$

Remarque : La commande en cours est égale à zéro.

Commande d'Urgence

Le système de distribution des intrants de santé tel que conçu a pour but d'éviter les commandes d'urgence. Cependant, il est prévu une procédure de commande d'urgence. Comme signalé dans les sections précédentes, si les niveaux de stock sont au point de commande d'urgence ou en dessous, une commande d'urgence doit être placée immédiatement. La procédure de commande d'urgence est identique à celle de la commande routinière expliquée ci-dessus. A la seule différence qu'il faut préciser qu'il s'agit d'une commande d'urgence.

V. Réception et Emmagasinage

Réception des intrants de santé

A la réception des intrants de santé commandés:

- Vérifier qu'ils sont accompagnés d'un bordereau de livraison/transfert des intrants de santé
- Vérifier que les quantités reçues correspondent à celles figurant sur le rapport-bon de commande.
- Vérifier qu'ils sont utilisables (bonne condition, non endommagés, non périmés ou non en voie de péremption).
- Accuser réception des intrants de santé livrés.
- Archiver une copie du bordereau de livraison/transfert des intrants de santé.
- Inscrire les quantités reçues sur les fiches de stock. Chaque produit a une fiche de stock.

Après ce bref contrôle, les intrants de santé peuvent être rangés au lieu de stockage.

Stockage des intrants de santé

Un bon stockage permet d'avoir des intrants de santé toujours disponibles, accessibles, et en bon état.

Une bonne organisation du magasin d'entreposage passe par:

- La mise en place des mesures de sécurité, et
- L'application effective des directives pour un bon entreposage.

Mesures de sécurité

Les mouvements de stock (entrées/sorties) sont contrôlés en:

- Fermant le magasin à clé et en y limitant l'accès aux seules personnes autorisées. La reproduction de la clé du magasin doit se faire en nombre très limité. Une clé du magasin doit toujours être disponible auprès du chef de service ou de son intérimaire en cas d'absence pour maladie, vacances, réunions, etc.
- S'assurant que les livraisons et les réceptions de stocks correspondent aux pièces justificatives.
- Mettant à jour les fiches de stock
- Protégeant le magasin contre les vols et incendies.

Entreposage des intrants de santé

En général, les intrants de santé doivent être protégés du soleil, de la chaleur et de l'eau. Suivez les recommandations de bon entreposage du fabricant. Ces directives parfois figurent soit sur le carton soit sur la boîte contenant le produit. Le tableau ci-dessous résume les directives d'un bon entreposage à appliquer dans tous les magasins de stockage.

Tableau 5 : Directives pour un bon entreposage

1.	Nettoyer et désinfecter régulièrement le magasin
2.	Entreposer les Intrants de santé dans une pièce sans humidité bien éclairée et bien aérée, à l'abri de la lumière directe du soleil
3.	Vérifier qu'il n'y ait pas de fuite d'eau dans la pièce
4.	S'assurer que le local soit en dur et fermé à clé
5.	Vérifier que le matériel anti-incendie est disponible et accessible, et s'assurer que le personnel est formé à son utilisation
6.	Entreposer les Intrants de santé à l'abri des insecticides, des Intrants de santé dangereux, des vieux dossiers, des fournitures de bureau et de tout autre équipement,
7.	Entreposer les cartons à au moins 10 cm du sol, 30 cm des murs et des autres piles, et à une hauteur de 2,5m maximum,
8.	Entreposer les Intrants de santé de manière à faciliter le principe de rangement par ordre alphabétique, par forme pharmaceutique et entreposer les de manière à faciliter le comptage et la gestion des Intrants de santé,
9.	Disposer les cartons de sorte que les flèches (↑) étiquettes d'identification, les dates de péremption et les dates de fabrication soient clairement visibles,
10.	Garder les stupéfiants et autres substances contrôlés dans un endroit fermé à clé,
11.	Entreposer les Intrants de santé en latex loin des moteurs électriques et des lumières fluorescentes,
12.	Maintenir les conditions frigorifiques, y compris la chaîne de froid, pour les Intrants de santé qui en ont besoin,
13.	Entreposer les Intrants de santé par date de péremption en respectant le principe du « Premier Périment, Premier Sorti (PPPS) »,
14.	Assurer l'inventaire des intrants de santé à chaque période déterminée et séparer les intrants de santé endommagés ou périmés, les retirer de l'inventaire immédiatement, et les détruire conformément aux procédures en vigueur.

Conduire un inventaire physique

L'inventaire est un processus qui consiste à:

- Déterminer le nombre exact d'articles disponibles et utilisables de chaque intrant qui se trouve au magasin ou au lieu de stockage.
- Vérifier que les stocks disponibles correspondent aux quantités enregistrées sur les fiches de stock.
- Déterminer le nombre d'articles inutilisables en stock (intrants de santé détériorés ou périmés).
- Identifier toute mesure corrective permettant de garantir que les articles sont reçus, emmagasinés et comptabilisés selon les procédures en vigueur.
- Prévenir toutes possibilités de fraude, de vol ou de perte.

Tableau 6 : Les différentes étapes d'un inventaire physique

ETAPES	ACTIONS	NOTES
1.	Séparer et compter les articles périmés ou endommagés.	Enregistrer la quantité des intrants de santé endommagés ou périmés sur la <i>Fiche de Stock</i> et dans la colonne « Sortie ». Dans la colonne « Observation » de la fiche de stock, inscrire une brève explication sur les intrants de santé périmés ou endommagés.
2.	Compter séparément chaque produit utilisable.	Si un intrant comprend plusieurs lots avec des dates de péremption différente, compter et enregistrer chaque lot différemment.
3.	Inscrire au stylo rouge sur la Fiche de Stock : la date de l'inventaire physique, la mention « Inventaire Physique », les pertes et ajustements et les quantités comptées.	Les pertes et autres intrants de santé manquants et les intrants de santé transférés à une autre structure seront enregistrés dans la colonne «Sortie » tandis que les intrants de santé empruntés ou ceux reçus d'une autre structure seront enregistrés dans la colonne «Entrée ». Pour chaque transfert effectué ou perte constatée, donner une brève explication dans la colonne «Observation ». Enregistrer la quantité comptée dans la colonne « Stock» de la Fiche de Stock
4.	Inscrire lisiblement la date de péremption sur chaque boîte ou carton.	Certains intrants de santé tels que les condoms peuvent ne pas avoir une date de péremption explicite. Si tel est le cas, alors référez-vous à la date de fabrication auquel vous ajouterez la durée de vie du produit concerné.
5.	Disposer les intrants de santé en stock en suivant le principe de gestion Premier Périmé, Premier Sorti (si cela s'avère nécessaire).	

Inspection visuelle

Une inspection visuelle consiste à examiner visuellement les intrants de santé et leurs emballages pour identifier des problèmes concernant la qualité des intrants de santé.

Pour préserver la qualité des intrants de santé, il est important de procéder à une inspection visuelle. Elle doit être menée chaque fois que les intrants de santé sont reçus, livrés, ou distribués, ou pendant un inventaire physique. Pendant une inspection visuelle, veuillez vérifier:

- **L'intégrité de l'emballage et du produit:** rechercher des dommages à l'emballage (déchirures, perforations, eau ou huile) et aux intrants de santé (comprimés brisés ou broyé, boîtes cassées).
- **Le défaut de Fabrication:** intrants de santé incomplets, information d'identification manquante ou peu lisible.
- **Les étiquettes:** s'assurer que les intrants de santé ont des étiquettes avec des dates de fabrication ou de péremption, le numéro du lot et le nom du fabricant.

Pour les comprimés et capsules, s'assurer que:

- Les comprimés/capsules sont de même taille, forme et couleur
- Les comprimés/capsules ont les mêmes annotations
- Pas de défections telles que des taches, fissures
- Pas d'odeur anormale quand la boîte est ouverte
- Pas de comprimés brisés ou de capsules vides, ouverts, ou cassées.

Gérer les intrants de santé endommagés ou périmés

Les systèmes de gestion des intrants de santé essaient toujours de minimiser la quantité d'intrants de santé endommagés ou périmés. Cependant, si des intrants de santé endommagés ou périmés sont découverts lors de réception d'une livraison, d'une inspection visuelle ou d'un inventaire physique, ces stocks doivent être retirés immédiatement du stock et gardés séparément de sorte qu'ils ne soient plus utilisés ou distribués.

Ils seront ensuite détruits selon les directives du Ministère de la Santé. Ces directives sont contenues dans le « **Guide de destruction des médicaments périmés ou avariés** » développé par la Direction de l'Agence du Médicament de Madagascar. Ce guide décrit clairement les étapes et procédures à suivre et définit le rôle des différents intervenants au processus de destruction des intrants de santé périmés ou avariés. Tous les gestionnaires des intrants de santé sont priés d'obtenir une copie du guide qui leur servira d'outil de référence au niveau de leur service respectif.

